

Fiches d'interrogatoire par symptôme

Manuel du Généraliste — *Du Symptôme au Diagnostic* · Outil de raisonnement pour l'interne

64 fiches · interrogatoire ciblé · diagnostic différentiel · signe pathognomonique / d'orientation · red flags — Dr Mario Fuiano

Mode d'emploi. Chaque fiche suit la même logique de consultation : **1)** ce qu'on demande à l'interrogatoire pour trier les hypothèses, **2)** les diagnostics différentiels avec le signe qui pointe vers chacun, **3)** le signe **pathognomonique** quand il existe — sinon le meilleur **signe d'orientation** à défaut, **4)** les **red flags** à ne jamais manquer.

/KILLCRITIC **À garder en tête :** les vrais signes pathognomoniques sont **rare**s en médecine — la plupart des cases « pathognomonique » donnent en réalité un signe d'*orientation forte*, c'est dit explicitement. Ces fiches sont un **support de raisonnement**, pas un protocole : elles ne dispensent ni de l'examen clinique complet ni des recommandations en vigueur (HAS, sociétés savantes). Contenu rédigé au niveau attendu d'un interne, à confronter au manuel source et à la clinique du patient.

■ Interrogatoire ■ Différentiels ■ Pathognomonique / orientation ■ Red flags

01 Acouphène

ORL / Neuro

INTERROGATOIRE CIBLÉ

Caractériser

- Uni- ou bilatéral ?
- Pulsatile (synchrone du pouls) ou continu/sifflement ?
- Tonalité aiguë (cochléaire) vs grave (transmission) ?
- Permanent ou intermittent ; aggravé la nuit/silence ?

Signes associés

- Hypoacousie, plénitude d'oreille ?
- Vertiges rotatoires ?
- Otorrhée, otalgie ?
- Céphalées, signes neuro focaux ?

Terrain / étio

- Exposition au bruit, traumatisme sonore ?
- Ototoxiques (aminosides, furosémide, AINS, aspirine, cisplatine, quinine) ?
- HTA, athérome, souffle cervical ?
- Anxiété, troubles du sommeil ?

DIFFÉRENTIELS & SIGNES DISCRIMINANTS

Acouphène pulsatile	Synchrone du pouls → cause vasculaire (sténose carotidienne, fistule, tumeur du glomus, HTIC) : à explorer impérativement
Surdité de perception unilat. + acouphène	Évoquer neurinome de l'acoustique → IRM
Maladie de Ménière	Triade : acouphène grave + surdité fluctuante + vertige rotatoire
Presbycusie / trauma sonore	Acouphène aigu bilatéral, audiométrie : scotome sur 4 kHz (trauma)

PATHOGNOMONIQUE / ORIENTATION FORTE

Pas de signe pathognomonique. Orientation forte : un acouphène PULSATILE unilatéral est vasculaire jusqu'à preuve du contraire ; un acouphène unilatéral + surdité de perception impose l'IRM (neurinome).

⚠ RED FLAGS / URGENCES

- Acouphène pulsatile unilatéral (cause vasculaire/tumorale)
- Surdité brusque associée (urgence, corticoïdes)
- Signes neurologiques centraux, vertige avec nystagmus central

INTERROGATOIRE CIBLÉ

La/les ADP

- Localisation (cervicale, sus-clav, axillaire, inguinale) ?
- Taille, évolution, vitesse d'apparition ?
- Unique vs polyadénopathie ?
- Douleur (inflammatoire) vs indolore (néoplasique/lymphome) ?

Signes associés

- Fièvre, sueurs nocturnes, amaigrissement (signes B) ?
- Prurit (Hodgkin) ?
- Porte d'entrée infectieuse dans le territoire de drainage ?

Terrain

- Contage (griffure de chat, tuberculose, IST, toxoplasmose) ?
- Voyage, animaux ?
- Facteurs de risque néoplasiques (tabac/alcool si cervical) ?

DIFFÉRENTIELS & SIGNES DISCRIMINANTS

ADP inflammatoire aiguë	Chaude, douloureuse, porte d'entrée → adénite réactionnelle
Sus-claviculaire	TOUJOURS suspecte : Troisier à gauche (néo digestif/pelvien), médiastin/poumon à droite
Polyadénopathie + signes B	Lymphome, leucémie, VIH, MNI, toxoplasmose
ADP dure, fixée, indolore	Métastase ganglionnaire ou lymphome → biopsie

PATHOGNOMONIQUE / ORIENTATION FORTE

Ganglion de Troisier (sus-claviculaire gauche) = orientation forte vers néoplasie viscérale. Pas de signe strictement pathognomonique ; toute ADP > 2 cm persistant > 3-4 sem sans cause impose la biopsie (PAS la ponction seule pour un lymphome).

△ RED FLAGS / URGENCES

- ADP sus-claviculaire (toujours)
- ADP dure fixée + signes B
- Syndrome cave supérieur (ADP médiastinale)

03 Algie faciale

INTERROGATOIRE CIBLÉ

Profil évolutif (clé)

- Aiguë brutale vs chronique paroxystique ?
- Durée des accès (secondes = névralgie V ; 15-180 min = AVF ; heures = migraine) ?
- Périodicité, horaire (AVF : nocturne, en salves) ?

Topographie / type

- Territoire (V1/V2/V3 ?) ?
- Décharge électrique (névralgie) vs pulsatile (migraine) vs broiement ?
- Zone gâchette déclenchante (mastication, contact) ?

Signes associés

- Larmoiement, rhinorrhée, myosis homolat. (AVF/dysautonomie) ?
- Aura, photophobie, nausées (migraine) ?
- Fièvre, AEG (Horton si > 50 ans) ?

DIFFÉRENTIELS & SIGNES DISCRIMINANTS

Névralgie du trijumeau essentielle	Décharges fulgurantes V2/V3, zone gâchette, examen neuro normal ; si déficit → forme symptomatique (IRM)
Algie vasculaire de la face	Douleur périorbitaire atroce en salves + signes dysautonomiques homolatéraux, agitation
Migraine	Hémicrânie pulsatile, photophonophobie, nausées, ± aura
Maladie de Horton	Sujet > 50 ans, céphalée temporale, artère indurée, claudication mâchoire, VS ↑ → urgence (cécité)

PATHOGNOMONIQUE / ORIENTATION FORTE

Zone gâchette + décharges électriques fulgurantes dans un territoire du V = quasi pathognomonique de névralgie du trijumeau. Signes dysautonomiques unilatéraux (larmoiement+myosis+rhinorrhée) pendant des salves = AVF.

△ RED FLAGS / URGENCES

- Horton (> 50 ans, VS ↑, BAT) → corticoïdes en urgence
- Algie faciale + déficit neuro → forme symptomatique
- Première crise brutale, AEG, fièvre

INTERROGATOIRE CIBLÉ

Caractériser

- Aiguë vs chronique (> 6 mois) ?
- Cyclique (cataméniale) vs permanente ?
- Latéralisée ou médiane ?
- Rythme : mictionnel, défécatoire, rapports (dyspareunie) ?

Gynéco

- DDR, contraception, possibilité de grossesse (β -hCG) ?
- Métrorragies, leucorrhées ?
- Dysménorrhée, dyspareunie profonde (endométriose) ?

Digestif/uro

- Transit, signes urinaires, fièvre ?

DIFFÉRENTIELS & SIGNES DISCRIMINANTS

GEU	Femme en âge de procréer + douleur + métrorragies + β -hCG+ → URGENCE
Salpingite (PID)	Douleur bilatérale + fièvre + leucorrhées + douleur à la mobilisation utérine
Torsion d'annexe / kyste	Douleur brutale unilatérale + masse + vomissements
Endométriose	Douleur cataméniale + dyspareunie profonde + dyschésie cataméniale
Colique néphrétique	Douleur lombo-pelvienne paroxystique irradiant aux OGE, agitation

PATHOGNOMONIQUE / ORIENTATION FORTE

Pas de pathognomonique unique. Orientation majeure : toute algie pelvienne chez une femme en âge de procréer = β -hCG d'emblée (éliminer GEU). Douleur cataméniale + dyspareunie profonde oriente fortement vers l'endométriose.

△ RED FLAGS / URGENCES

- GEU (β -hCG + douleur + métrorragies)
- Torsion d'annexe
- Pelvipéritonite / sepsis
- Appendicite

05 Alopécie

INTERROGATOIRE CIBLÉ

Type de chute

- Diffuse vs localisée (plaques) ?
- Aiguë (effluvium) vs progressive ?
- Cicatricielle (disparition des orifices) vs non cicatricielle ?
- Cheveux cassés vs chute à la racine ?

Facteurs

- Accouchement, fièvre, chirurgie, régime, stress 2-3 mois avant (effluvium télogène) ?
- Médicaments (anticoagulants, rétinoïdes, chimio, lithium, β -bloquants, AINS) ?
- Carence martiale, dysthyroïdie ?
- Traction, manipulation (trichotillomanie) ?

Associé

- Prurit, squames, signes inflammatoires (teigne, lichen, lupus) ?

DIFFÉRENTIELS & SIGNES DISCRIMINANTS

Pelade	Plaques alopeciques nettes, non cicatricielles, cheveux en point d'exclamation
Effluvium télogène	Chute diffuse 2-3 mois après facteur déclenchant, réversible
Alopécie androgénétique	Golfes/vertex (homme), raie élargie (femme), progressive
Teigne	Plaque squameuse + cheveux cassés courts chez l'enfant → mycologie
Alopécie cicatricielle	Lichen plan, lupus, pseudo-pelade → biopsie indispensable

PATHOGNOMONIQUE / ORIENTATION FORTE

Cheveux peladiques 'en point d'exclamation' (effilés à la base) = quasi pathognomonique de pelade. Disparition des orifices pilaires = alopécie cicatricielle (biopsie). Carré de traction positif = chute active.

△ RED FLAGS / URGENCES

- Alopécie cicatricielle (lupus, lichen) → biopsie pour ne pas perdre le capital
- Signes de lupus systémique associés

INTERROGATOIRE CIBLÉ**Caractériser**

- Réactionnelle (effort, fin de journée) vs organique (matinale, permanente) vs psychique ?
- Aiguë vs chronique (> 1 mois) ?
- Retentissement, amaigrissement associé ?

Orientation organique

- Fièvre, sueurs, AEG (néo, infection chronique, TB) ?
- Pâleur, dyspnée (anémie) ?
- Soif/polyurie (diabète), frilosité (hypothyroïdie), mélanodermie (Addison) ?
- Médicaments (β-bloquants, hypnotiques, antihistaminiques) ?

Orientation psy

- Troubles du sommeil, anhédonie, tristesse, anxiété ?
- Asthénie maximale le matin s'améliorant dans la journée (dépression) ?

DIFFÉRENTIELS & SIGNES DISCRIMINANTS

Asthénie organique	Permanente, matinale, progressive, AEG → bilan (NFS, VS/CRP, TSH, glycémie, iono, ferritine)
Asthénie psychogène	Matinale s'améliorant, plaintes multiples, contexte anxiodépressif
Asthénie réactionnelle	Surmenage, dette de sommeil, réversible au repos
Causes endocriniennes	Hypothyroïdie, Addison, diabète, hypercalcémie

PATHOGNOMONIQUE / ORIENTATION FORTE

Pas de pathognomonique. Orientation clé : asthénie qui S'AGGRAVE au cours de la journée = plutôt organique ; asthénie MAXIMALE au réveil s'améliorant = plutôt dépressive. AEG (asthénie+anorexie+amaigrissement) impose un bilan organique.

△ RED FLAGS / URGENCES

- AEG avec amaigrissement (néoplasie)
- Mélanodermie + hypotension (insuffisance surrénale)
- Asthénie + fièvre prolongée

07 **Bouffées de chaleur****INTERROGATOIRE CIBLÉ****Caractériser**

- Sensation de chaleur ascendante + sueurs + flush ?
- Fréquence, horaire (nocturnes) ?
- Facteurs déclenchants (repas, alcool, émotions) ?

Contexte femme

- Âge, statut ménopausique, DDR, aménorrhée ?
- Autres signes climatiques (sécheresse vaginale, troubles de l'humeur) ?

Drapeaux atypiques

- Diarrhée, flush déclenché (carcinoïde) ?
- Palpitations, HTA paroxystique, céphalées (phéochromocytome) ?
- Médicaments (inducteurs de l'ovulation, anti-œstrogènes, vasodilatateurs) ?

DIFFÉRENTIELS & SIGNES DISCRIMINANTS

Ménopause / périménopause	Femme ~50 ans + aménorrhée + bouffées vasomotrices : diagnostic clinique
Syndrome carcinoïde	Flush + diarrhée + bronchospasme → 5-HIAA urinaire
Phéochromocytome	Triade céphalées-sueurs-palpitations + HTA paroxystique → métanéphrines
Iatrogène	Tamoxifène, analogues LHRH, inhibiteurs de l'aromatase, vasodilatateurs

PATHOGNOMONIQUE / ORIENTATION FORTE

Chez la femme ménopausée, le tableau est clinique. Orientation vers une cause secondaire si : flush + diarrhée (carcinoïde) ou triade céphalée-sueur-palpitation + HTA paroxystique (phéochromocytome).

△ RED FLAGS / URGENCES

- Flush + diarrhée + valvulopathie (carcinoïde)
- HTA paroxystique sévère (phéochromocytome)

INTERROGATOIRE CIBLÉ

Mécanique vs inflammatoire

- Horaire mécanique (effort, soir) vs inflammatoire (réveil nocturne, dérouillage matinal) ?
- Raideur, position antalgique ?
- Traumatisme, faux mouvement ?

Radiculalgie

- Irradiation dans le membre supérieur (NCB) ? Territoire ?
- Paresthésies, déficit moteur ?

Drapeaux

- Fièvre, AEG, ATCD néo (métastase, spondylodiscite) ?
- Signes médullaires (troubles sphinctériens, Lhermitte, marche) ?
- Céphalée brutale + raideur (HSA, méningite) ?

DIFFÉRENTIELS & SIGNES DISCRIMINANTS

Cervicalgie commune	Mécanique, contracture, examen neuro normal
Névralgie cervico-brachiale	Douleur radiculaire systématisée + signes d'irritation/déficit
Myélopathie cervicarthrosique	Troubles de la marche, syndrome pyramidal aux MI
Cervicalgie symptomatique	Fièvre/AEG → spondylodiscite, tumeur ; raideur fébrile → méningite

PATHOGNOMONIQUE / ORIENTATION FORTE

Pas de pathognomonique. Signe d'orientation grave : cervicalgie + syndrome médullaire (Lhermitte, troubles de la marche, syndrome pyramidal) = myélopathie → IRM urgente. Torticolis fébrile + raideur méningée = urgence.

▲ RED FLAGS / URGENCES

- Syndrome médullaire (myélopathie, compression)
- Fièvre + raideur (spondylodiscite, méningite)
- Cervicalgie post-traumatique (instabilité)
- AEG / ATCD néoplasique

09 Constipation

INTERROGATOIRE CIBLÉ

Définir

- Récente (alarme) vs chronique/ancienne ?
- < 3 selles/sem, selles dures, dyschésie, exonération incomplète ?
- Alternance diarrhée-constipation ?

Signes d'alarme

- Modification récente du transit > 50 ans ?
- Rectorragies, méléna, anémie ?
- Amaigrissement, AEG, ATCD familial de CCR ?

Secondaire

- Médicaments (opioïdes, anticholinergiques, fer, antiHTA, codéine) ?
- Hypothyroïdie, hypercalcémie, hypokaliémie, diabète ?
- Syndrome occlusif (douleurs, vomissements, arrêt des matières) ?

DIFFÉRENTIELS & SIGNES DISCRIMINANTS

Constipation fonctionnelle	Ancienne, sans signe d'alarme, terrain typique
Cancer colorectal	Constipation RÉCENTE > 50 ans + rectorragies/anémie → coloscopie
Cause métabolique/médicamenteuse	Hypothyroïdie, hypercalcémie, hypokaliémie, opioïdes
Occlusion	Constipation aiguë + douleurs + vomissements + arrêt des gaz

PATHOGNOMONIQUE / ORIENTATION FORTE

Pas de pathognomonique. Orientation cardinale : toute constipation RÉCENTE et durable après 50 ans, ou avec rectorragie/anémie, impose la coloscopie (cancer). Constipation + douleur + arrêt des gaz = occlusion.

▲ RED FLAGS / URGENCES

- Modification récente du transit > 50 ans
- Rectorragies, anémie ferriprive, amaigrissement
- Syndrome occlusif

INTERROGATOIRE CIBLÉ

Caractériser

- Vraie crampe (contraction douloureuse brève, palpable) ?
- Localisation (mollet ++), horaire (nocturne) ?
- Effort déclenchant ou repos ?
- Fréquence, retentissement sur le sommeil ?

Causes

- Médicaments (diurétiques, statines, β 2-mimétiques, β -bloquants) ?
- Déshydratation, dialyse, sueurs ?
- Grossesse ?
- Alcool, hypothyroïdie ?

Signes associés

- Déficit moteur, amyotrophie, fasciculations (SLA, myopathie) ?
- Troubles ioniques (Ca, Mg, K, Na) ?
- Artériopathie (claudication) ?

DIFFÉRENTIELS & SIGNES DISCRIMINANTS

Crampe essentielle/idiopathique	Nocturne, mollet, examen normal, sujet âgé/sportif
Crampe métabolique	Iatrogène (diurétiques, statines), trouble hydroélectrolytique, dialyse
Pathologie neuromusculaire	Crampes + fasciculations + amyotrophie → SLA ; CPK ↑ → myopathie
Tétanie/spasmophilie	Paresthésies péri-buccales, Chvostek/Trousseau, hypocalcémie/hypomagnésémie

PATHOGNOMONIQUE / ORIENTATION FORTE

Signe de Trousseau / Chvostek = orientation vers téτανie (hypocalcémie). Crampes + fasciculations diffuses + amyotrophie = signal d'alarme SLA. Sinon pas de pathognomonique : la majorité sont idiopathiques.

⚠ RED FLAGS / URGENCES

- Crampes + fasciculations + déficit (SLA)
- CPK très élevées (rhabdomyolyse sous statine)
- Troubles ioniques sévères

11 Diarrhée aiguë

INTERROGATOIRE CIBLÉ

Caractériser

- Durée (< 14 j = aiguë), nombre de selles ?
- Hydrique vs glairo-sanglante (syndrome dysentérique) ?
- Fièvre, douleurs, vomissements ?

Contexte

- Toxi-infection collective, même repas ?
- Voyage récent (tourista, paludisme si fièvre) ?
- Antibiothérapie récente (C. difficile) ?
- Médicaments (laxatifs, ATB, colchicine, metformine) ?

Gravité / terrain

- Signes de déshydratation (soif, pli cutané, oligurie, hypoTA) ?
- Âge extrême, immunodépression, comorbidités ?

DIFFÉRENTIELS & SIGNES DISCRIMINANTS

Diarrhée hydrique virale/toxinique	Selles liquides abondantes, peu/pas de fièvre, contexte épidémique
Syndrome dysentérique	Selles glairo-sanglantes + fièvre + ténésme → bactérie invasive (Shigella, Campylobacter, Salmonella)
Colite à C. difficile	Diarrhée post-ATB ± pseudomembranes → toxines
Cause non infectieuse	Médicaments, poussée de MICI, fécalome (fausse diarrhée)

PATHOGNOMONIQUE / ORIENTATION FORTE

Syndrome dysentérique (selles afécales glairo-sanglantes + ténésme + épreintes) = orientation forte vers mécanisme invasif/inflammatoire (coproculture). La gravité se juge sur la DÉSHYDRATATION et le terrain, pas sur le nombre de selles.

⚠ RED FLAGS / URGENCES

- Déshydratation sévère, choc
- Diarrhée glairo-sanglante fébrile + terrain fragile
- Sepsis, syndrome pseudo-occlusif (colectasie)
- Retour de zone d'endémie palustre

INTERROGATOIRE CIBLÉ**Définir le mécanisme**

- > 4 semaines ?
- Selles : grasses/mastic flottantes (malabsorption) vs hydriques vs glairo-sanglantes ?
- Horaire : nocturne (organique) vs diurne post-prandial ?
- Cède au jeûne (osmotique) vs persiste (sécrétoire) ?

Signes associés

- Amaigrissement, AEG, carences (anémie, œdèmes) ?
- Douleurs, syndrome rectal, faux besoins ?
- Manifestations extra-digestives (MICI, hyperthyroïdie, flush) ?

Terrain

- Médicaments, alcool, chirurgie digestive ?
- Voyage, immunodépression ?

DIFFÉRENTIELS & SIGNES DISCRIMINANTS

Malabsorption	Stéatorrhée + amaigrissement + carences → maladie coeliaque, insuff. pancréatique
MICI	Diarrhée glairo-sanglante chronique + douleurs + AEG + signes extra-dig.
Diarrhée motrice	Post-prandiale impérieuse, aliments non digérés → hyperthyroïdie, neuropathie diabétique, TFI
Cause sécrétoire/tumorale	Persiste au jeûne, nocturne, hypokaliémie → VIPome, carcinoïde, colite microscopique

PATHOGNOMONIQUE / ORIENTATION FORTE

Pas de pathognomonique. Orientation par le mécanisme : diarrhée qui PERSISTE au jeûne et réveille la nuit = organique/sécrétoire (à explorer) ; stéatorrhée = malabsorption ; diarrhée motrice = post-prandiale, impérieuse.

△ RED FLAGS / URGENCES

- AEG, amaigrissement, syndrome carenciel
- Diarrhée glairo-sanglante (MICI, cancer)

- Diarrhée nocturne organique

13 **Difficultés sexuelles****INTERROGATOIRE CIBLÉ****Préciser le trouble**

- Homme : trouble du désir, dysfonction érectile, éjaculation, douleur ?
- Femme : désir, excitation, dyspareunie, anorgasmie ?
- Primaire (toujours) vs secondaire (acquis) ?
- Permanent vs situationnel (oriente vers psychogène) ?

DE : organique vs psychogène

- Érections nocturnes/matinales conservées (psychogène) ou abolies (organique) ?
- FdR vasculaires (DE = marqueur d'athérome) : HTA, diabète, tabac, dyslipidémie ?
- Médicaments (β-bloquants, diurétiques, antidépresseurs ISRS, neuroleptiques) ?

Hormonal/psy

- Baisse de libido, gynécomastie (hypogonadisme, hyperprolactinémie) ?
- Contexte de couple, anxiété de performance, dépression ?

DIFFÉRENTIELS & SIGNES DISCRIMINANTS

DE organique vasculaire	Installation progressive, érections matinales abolies, FdR CV → DE = sentinelle coronarienne
DE psychogène	Début brutal, situationnel, érections nocturnes conservées
Cause endocrinienne	Hypogonadisme, hyperprolactinémie (+ galactorrhée), dysthyroïdie
Iatrogène	Très fréquent : antihypertenseurs, psychotropes

PATHOGNOMONIQUE / ORIENTATION FORTE

Conservation des érections nocturnes/matinales spontanées = orientation forte vers une DE psychogène ; leur disparition progressive = organique. La DE est un marqueur précoce d'athérome → bilan cardiovasculaire.

△ RED FLAGS / URGENCES

- DE = signal d'alerte coronarien (bilan CV)

- Hyperprolactinémie (adénome) si baisse de libido + galactorrhée

INTERROGATOIRE CIBLÉ**Mono ou binoculaire (CLÉ)**

- Disparaît en occluant un œil (binoculaire = atteinte oculomotrice) ou persiste (monoculaire = ophtalmo) ?
- Horizontale, verticale, oblique ?
- Permanente vs intermittente/fluctuante (myasthénie) ?

Mode d'installation

- Brutale (vasculaire) vs progressive ?
- Douleur associée (anévrisme du III, Tolosa-Hunt, Horton) ?

Signes associés

- Ptosis, mydriase (III) ?
- Céphalées, signes neuro, fièvre ?
- Exophtalmie, signes thyroïdiens ?
- Fluctuation à la fatigue (myasthénie) ?

DIFFÉRENTIELS & SIGNES DISCRIMINANTS

Paralysie du III	Ptosis + œil en abduction + mydriase : si DOULOUREUX → anévrisme (urgence), si mydriase respectée → cause ischémique (diabète)
Paralysie du VI	Déficit d'abduction, diplopie horizontale ; peu localisateur (HTIC)
Paralysie du IV	Diplopie verticale/torsion, tête inclinée du côté opposé
Myasthénie	Diplopie + ptosis FLUCTUANTS, aggravés à la fatigue/le soir
Orbitopathie dysthyroïdienne	Diplopie + exophtalmie + rétraction palpébrale

PATHOGNOMONIQUE / ORIENTATION FORTE

Diplopie binoculaire (qui disparaît à l'occlusion d'un œil) = atteinte oculomotrice à explorer. Le III DOULOUREUX avec mydriase = anévrisme jusqu'à preuve du contraire (urgence). Caractère FLUCTUANT à la fatigue = myasthénie.

△ RED FLAGS / URGENCES

- III douloureux + mydriase (anévrisme communicante post.) → imagerie urgente
- Diplopie + céphalée + AEG > 50 ans (Horton)
- Diplopie + autres signes du tronc (AVC)

15 **Dorsalgies****INTERROGATOIRE CIBLÉ****Mécanique vs inflammatoire vs symptomatique**

- Horaire mécanique vs inflammatoire (2e partie de nuit, dérouillage) ?
- Effort déclenchant ?
- Permanente, non soulagée par le repos (drapeau rouge) ?

Drapeaux rouges

- Âge < 20 / > 55 ans pour 1er épisode ?
- Fièvre, AEG, ATCD néoplasique (métastase, myélome) ?
- Douleur thoracique transfixiante (dissection aortique, IDM) ?
- Signes neuro (compression médullaire dorsale) ?

Viscéral projeté

- Lien avec repas, position (ulcère, pancréas, RGO) ?
- Signes cardiaques/pulmonaires ?

DIFFÉRENTIELS & SIGNES DISCRIMINANTS

Dorsalgie statique/fonctionnelle	Mécanique, jeune, examen normal, posturale
Tassement vertébral	Douleur aiguë, sujet âgé/ostéoporose ou myélome/métastase
Dorsalgie symptomatique	Inflammatoire/permanente + fièvre/AEG → spondylodiscite, tumeur
Douleur projetée viscérale	Cardiaque, aortique (dissection), pancréatique, pleuro-pulmonaire

PATHOGNOMONIQUE / ORIENTATION FORTE

Pas de pathognomonique. La dorsalgie est le siège classique des douleurs VISCÉRALES PROJETÉES : toute dorsalgie aiguë sans cause rachidienne évidente doit faire éliminer un IDM, une dissection aortique, une pancréatite. Rythme inflammatoire + fièvre = spondylodiscite.

△ RED FLAGS / URGENCES

- Dissection aortique / IDM (douleur transfixiante)
- Spondylodiscite (fièvre + douleur inflammatoire)
- Métastase/myélome (AEG, ATCD néo)
- Compression médullaire dorsale

INTERROGATOIRE CIBLÉ

Type

- Permanente vs à la marche (claudication) ?
- Périmètre de marche, soulagée à l'arrêt (artérielle) vs à la flexion/assis (canal lombaire étroit) ?
- Unilatérale brutale (ischémie aiguë, TVP) ?

Vasculaire

- Froideur, pâleur, abolition des pouls (ischémie) ?
- Œdème, douleur du mollet, chaleur (TVP) ?
- FdR : tabac, diabète, immobilisation, néo, chirurgie ?

Neuro/rhumato

- Trajet radiculaire (sciatique L5/S1, cruralgie L3/L4) ?
- Douleur articulaire, dérouillage ?

DIFFÉRENTIELS & SIGNES DISCRIMINANTS

Ischémie aiguë	5 P : Pain, Pallor, Pulselessness, Paresthesia, Paralysis → URGENCE revascularisation
TVP	Œdème unilatéral + douleur mollet + chaleur → score de Wells, D-dimères, écho-doppler
AOMI / claudication	Douleur à la marche, périmètre fixe, abolition de pouls, IPS abaissé
Sciatique/ cruralgie	Douleur radiculaire systématisée, Lasègue +
Canal lombaire étroit	Claudication neurogène, soulagée à la flexion antérieure

PATHOGNOMONIQUE / ORIENTATION FORTE

Les '5 P' + abolition brutale des pouls = ischémie aiguë (pathognomonique du tableau, urgence). TVP : aucun signe clinique n'est spécifique → score de probabilité + écho-doppler. Claudication artérielle (à distance fixe) vs neurogène (posture-dépendante) : la distinction se fait à l'interrogatoire.

△ RED FLAGS / URGENCES

- Ischémie aiguë (5 P)
- TVP avec risque d'EP
- Phlegmatia (TVP ilio-fémorale)
- Fasciite nécrosante (douleur >> signes locaux, sepsis)

17 Douleurs du membre supérieur

INTERROGATOIRE CIBLÉ

Type

- Articulaire (épaule ++), périarticulaire, ou projetée ?
- Mécanique vs nocturne (capsulite, tendinopathie) ?
- Trajet radiculaire (NCB) ?
- Effort/sport, mouvement déclenchant ?

Cardiaque (à éliminer)

- Douleur du bras gauche/mâchoire à l'effort, constrictive (angor/IDM) ?

Vasculaire/neuro

- Œdème, cyanose, lourdeur (TVP membre sup., défilé thoraco-brachial) ?
- Paresthésies nocturnes des 3 premiers doigts (canal carpien) ?

DIFFÉRENTIELS & SIGNES DISCRIMINANTS

Pathologie d'épaule	Tendinopathie de la coiffe, capsulite : douleur mécanique/nocturne, limitation
NCB	Douleur radiculaire systématisée + signes neuro
Syndrome du canal carpien	Paresthésies nocturnes médian, Tinel/Phalen +
Douleur cardiaque projetée	Bras gauche + effort + constriction → SCA
TVP du membre supérieur	Œdème + circulation collatérale, terrain (cathéter, effort)

PATHOGNOMONIQUE / ORIENTATION FORTE

Aucun pathognomonique. Orientation vitale : une douleur du membre supérieur GAUCHE liée à l'effort et constrictive doit faire éliminer un syndrome coronarien. Paresthésies nocturnes des 3 premiers doigts réveillant le patient = canal carpien.

△ RED FLAGS / URGENCES

- SCA (douleur projetée d'effort)
- TVP du membre supérieur (EP)
- Déficit moteur radiculaire/médullaire

INTERROGATOIRE CIBLÉ

Caractériser (OPQRST)

- Constrictive/en étau (angor) vs pointe/respiro-dépendante (pleuro-péricardique) vs transfixiante (dissection) ?
- Effort déclenchant, durée, trinitrosensibilité ?
- Irradiation (mâchoire, bras gauche, dos) ?

Les 5 urgences à éliminer

- SCA : effort, FdR CV, constriction prolongée ?
- EP : dyspnée brutale, contexte thrombo-embolique, douleur basithoracique ?
- Dissection aortique : douleur transfixiante migratrice, asymétrie tensionnelle ?
- Pneumothorax : douleur brutale + dyspnée, sujet longiligne ?
- Péricardite/tamponnade : douleur soulagée penché en avant, fièvre virale ?

Pariétal/digestif

- Reproduite à la palpation/mouvement (pariétal) ?
- Pyrosis, lien postural/repas (RGO, spasme œsophagien) ?

DIFFÉRENTIELS & SIGNES DISCRIMINANTS

SCA	Douleur constrictive rétrosternale > 20 min, FdR, ECG + troponine
Embolie pulmonaire	Dyspnée + douleur pleurale + tachycardie ; score de probabilité + D-dimères/angioTDM
Dissection aortique	Douleur transfixiante intense d'emblée, migratrice, asymétrie des pouls/TA
Péricardite	Douleur positionnelle, frottement, sus-décalage diffus concave
Cause pariétale/œsophagienne	Reproductible à la palpation / liée au RGO (diagnostic d'élimination)

PATHOGNOMONIQUE / ORIENTATION FORTE

Aucune sémiologie n'est 100 % fiable : la règle est d'ÉLIMINER les 5 urgences avant d'évoquer une cause bénigne. Orientations fortes : douleur transfixiante migratrice + asymétrie tensionnelle = dissection ; soulagement en antéflexion + frottement = péricardite.

▲ RED FLAGS / URGENCES

- SCA, EP, dissection aortique, pneumothorax, tamponnade — les 5 à éliminer systématiquement

INTERROGATOIRE CIBLÉ

Caractériser

- Primaire (dès la ménarche) vs secondaire (apparue secondairement) ?
- Chronologie / règles (J1 vs avant/après) ?
- Intensité, retentissement, absentéisme ?

Orientation organique

- Dyspareunie profonde, dyschésie/signes cataméniaux (endométriose) ?
- Ménorragies, masse (fibrome, adénomyose) ?
- DIU, infection (salpingite) ?
- Infertilité associée ?

DIFFÉRENTIELS & SIGNES DISCRIMINANTS

Dysménorrhée primaire essentielle	Début à l'adolescence, sans cause organique, prostaglandines
Endométriose	Dysménorrhée secondaire INVALIDANTE + dyspareunie profonde + infertilité
Adénomyose / fibrome	Dysménorrhée + ménorragies + utérus augmenté
Cause infectieuse	Salpingite chronique, contexte IST

PATHOGNOMONIQUE / ORIENTATION FORTE

Pas de pathognomonique. Orientation forte : dysménorrhée SECONDAIRE, invalidante, avec dyspareunie profonde et/ou infertilité = endométriose jusqu'à preuve du contraire.

▲ RED FLAGS / URGENCES

- Dysménorrhée secondaire récente et croissante
- Endométriose (impact fertilité)

INTERROGATOIRE CIBLÉ**Caractériser**

- Ancienneté (> 3 semaines = alarme) ?
- Fumeur/buveur (cancer laryngé) ?
- Permanente vs intermittente, voix forcée (malmenage) ?
- Évolution, fausses routes associées ?

Étiologie

- Contexte infectieux (laryngite aiguë) ?
- RGO, toux chronique ?
- Chirurgie cervicale/thoracique récente, goitre (paralysie récurrentielle) ?
- Médicaments (corticoïdes inhalés, anticholinergiques) ?

DIFFÉRENTIELS & SIGNES DISCRIMINANTS

Laryngite aiguë	Dysphonie fébrile virale, régressive < 1 sem
Cancer du larynx	Dysphonie > 3 sem chez fumeur/buveur → laryngoscopie IMPÉRATIVE
Paralysie récurrentielle	Voix bitonale + fausses routes → cause médiastinale/thyroïdienne/néo
Nodules/forçage vocal	Dysphonie chronique du professionnel de la voix

PATHOGNOMONIQUE / ORIENTATION FORTE

Pas de pathognomonique. Règle d'or : toute dysphonie persistant > 3 semaines, surtout chez un fumeur/buveur, impose une laryngoscopie (cancer). Voix bitonale = paralysie d'une corde (rechercher cause sur le trajet du récurrent).

▲ RED FLAGS / URGENCES

- Dysphonie > 3 sem chez fumeur/buveur (cancer)
- Dyspnée laryngée associée
- Paralysie récurrentielle (cause tumorale)

21 **Dyspnées aiguës****INTERROGATOIRE CIBLÉ****Caractériser**

- Installation (minutes : OAP, EP, PNO, corps étranger) ?
- Position (orthopnée = cardiaque) ?
- Bruit (stridor = obstacle haut ; sibilants = bronchospasme) ?

Étiologies

- Douleur thoracique associée (EP, PNO, IDM) ?
- Fièvre, expectoration (pneumopathie) ?
- Contexte allergique, angio-œdème, fausse route ?
- ATCD cardiaque, asthme/BPCO ?

Gravité

- Signes de lutte, cyanose, sueurs, troubles de conscience, SpO2 ?
- Tachycardie, marbrures, hypoTA ?

DIFFÉRENTIELS & SIGNES DISCRIMINANTS

OAP cardiogénique	Orthopnée + crépitants + grésillement laryngé + cardiopathie
Embolie pulmonaire	Dyspnée brutale + douleur pleurale + tachycardie, auscultation souvent normale
Crise d'asthme/BPCO	Sibilants expiratoires, terrain, frein expiratoire
Pneumothorax	Douleur + tympanisme + abolition du murmure unilatéral
Pneumopathie	Fièvre + foyer de crépitants

PATHOGNOMONIQUE / ORIENTATION FORTE

Pas de pathognomonique unique. Orientations : orthopnée + crépitants bilatéraux = OAP ; dyspnée brutale isolée à auscultation normale = EP ; abolition unilatérale du murmure + tympanisme = pneumothorax. Les signes de GRAVITÉ priment sur le diagnostic.

▲ RED FLAGS / URGENCES

- Signes de lutte/épuisement, SpO2 effondrée, cyanose
- Troubles de conscience, bradypnée (épuisement)
- PNO compressif, OAP asphyxique, EP grave

INTERROGATOIRE CIBLÉ**Quantifier**

- Stade NYHA / mMRC (effort déclenchant) ?
- Évolution (progressive vs paliers) ?
- Orthopnée, dyspnée paroxystique nocturne (cardiaque) ?

Orientation

- Toux, expectoration chronique, tabac (BPCO) ?
- Sifflements, variabilité (asthme) ?
- Œdèmes des MI, prise de poids (IC) ?
- Anémie, dysthyroïdie, déconditionnement ?

DIFFÉRENTIELS & SIGNES DISCRIMINANTS

Insuffisance cardiaque	Dyspnée d'effort + orthopnée + œdèmes + crépitants ; BNP, ETT
BPCO	Tabac + dyspnée progressive + toux/expectoration ; EFR (TVO non réversible)
Asthme	Dyspnée variable + sibilants + réversibilité au bronchodilatateur
Pneumopathie interstitielle	Dyspnée + crépitants velcro + hippocratisme → TDM/EFR
Causes non cardio-pulmonaires	Anémie, hyperthyroïdie, obésité/déconditionnement

PATHOGNOMONIQUE / ORIENTATION FORTE

Pas de pathognomonique. Orientation : orthopnée + DPN + œdèmes = origine cardiaque ; tabagisme + TVO non réversible = BPCO ; réversibilité spirométrique = asthme ; crépitants 'velcro' + hippocratisme = fibrose.

△ RED FLAGS / URGENCES

- Dyspnée rapidement progressive (fibrose, néo, HTAP)
- Insuffisance cardiaque décompensée
- Anémie profonde

23 **Déficit neurologique transitoire****INTERROGATOIRE CIBLÉ****Caractériser le déficit**

- Focal (AIT) vs global (syncope, hypoglycémie) ?
- Installation BRUTALE déficitaire (AIT) vs progressive 'en tache d'huile' avec marche (aura migraineuse, crise) ?
- Durée (AIT < 1 h le plus souvent), récupération complète ?

Territoire

- Carotidien : hémiparésie, aphasie, cécité monoculaire (amaurose) ?
- Vertébro-basilaire : diplopie, vertige, dysarthrie, ataxie, déficit bilatéral ?

Terrain / DD

- FdR vasculaires, ACFA, souffle carotidien ?
- Glycémie capillaire (hypoglycémie mime tout) ?
- Céphalée, aura visuelle scintillante (migraine) ?
- Morsure de langue, perte d'urine, confusion post-critique (épilepsie) ?

DIFFÉRENTIELS & SIGNES DISCRIMINANTS

AIT	Déficit focal brutal, régressif, dans un territoire vasculaire → URGENCE (score ABCD2, bilan immédiat)
Aura migraineuse	Marche progressive des symptômes (scotome scintillant) > 5 min, puis céphalée
Crise épileptique focale	Symptômes 'positifs', marche bravais-jacksonienne, phase post-critique
Hypoglycémie	Sueurs, tremblements, resucrage efficace — à éliminer en premier

PATHOGNOMONIQUE / ORIENTATION FORTE

Pas de pathognomonique. Discriminants clés : déficit NÉGATIF d'emblée maximal et brutal = vasculaire (AIT) ; marche progressive de symptômes POSITIFS = aura/épilepsie. L'AIT est une urgence (risque d'AVC constitué à court terme) : glycémie capillaire systématique d'abord.

△ RED FLAGS / URGENCES

- AIT = urgence (prévention de l'AVC constitué)
- Hypoglycémie
- AIT répétés (sténose serrée, cardiopathie emboligène)

INTERROGATOIRE CIBLÉ

Caractériser

- Purulent abondant (gonocoque) vs clair/séreux (Chlamydia, mycoplasme) ?
- Dysurie, brûlures mictionnelles ?
- Délai depuis le rapport contaminant ?

Contexte IST

- Partenaire(s), rapports non protégés ?
- Autres signes (arthrite, conjonctivite = sd de Fiessinger-Leroy-Reiter) ?
- ATCD d'IST, statut VIH ?

DIFFÉRENTIELS & SIGNES DISCRIMINANTS

Urétrite gonococcique	Écoulement purulent jaune-verdâtre abondant, incubation courte (2-5 j)
Urétrite à Chlamydia/mycoplasme	Écoulement clair modéré, dysurie, incubation plus longue
Co-infection	Fréquente → traitement probabiliste couvrant gono + Chlamydia

PATHOGNOMONIQUE / ORIENTATION FORTE

Écoulement franchement purulent et abondant à incubation courte = orientation gonococcique ; écoulement clair/modéré = Chlamydia. En pratique on traite les deux (co-infection fréquente) et on dépiste les partenaires + autres IST.

△ RED FLAGS / URGENCES

- Orchi-épididymite, prostatite associée
- Dissémination gonococcique (arthrite, dermatite)

25 Épistaxis

INTERROGATOIRE CIBLÉ

Caractériser

- Antérieur (tache vasculaire) vs postérieur (abondant, déglutition) ?
- Uni vs bilatéral ?
- Spontané vs traumatisme/grattage ?
- Abondance, récurrence, retentissement (pâleur, malaise) ?

Étiologie générale

- HTA ?
- Anticoagulants/antiagrégants, trouble de l'hémostase ?
- Prise d'AINS/aspirine ?
- Épistaxis récurrentes unilatérales (tumeur, fibrome) ?
- Télangiectasies (maladie de Rendu-Osler) ?

DIFFÉRENTIELS & SIGNES DISCRIMINANTS

Épistaxis bénigne antérieure	Tache vasculaire de la cloison, jeune, récurrente, peu abondante
Épistaxis sur trouble de l'hémostase	AVK/AOD, thrombopénie, hémopathie → bilan d'hémostase
Épistaxis postérieure	Abondante, sujet âgé/HTA, risque hémodynamique
Cause tumorale	Épistaxis unilatérales répétées + obstruction → fibrome (ado), tumeur (adulte)

PATHOGNOMONIQUE / ORIENTATION FORTE

Pas de pathognomonique. Orientations : épistaxis unilatérales répétées au même endroit avec obstruction nasale = tumeur (à explorer) ; télangiectasies cutanéomuqueuses + épistaxis récurrentes familiales = maladie de Rendu-Osler.

△ RED FLAGS / URGENCES

- Épistaxis abondante/postérieure avec retentissement hémodynamique
- Trouble de l'hémostase / surdosage AVK
- Cause tumorale (unilatérale récurrente)

INTERROGATOIRE CIBLÉ

Caractériser

- Crises de rougeur + chaleur + douleur à type de brûlure des extrémités ?
- Déclenchées par la chaleur/l'effort, calmées par le froid/surélévation ?
- Topographie (pieds ++, mains) ?

Étiologie

- Syndrome myéloprolifératif connu (thrombocyémie, polyglobulie) ?
- Prurit, splénomégalie, thromboses ?
- Médicaments (inhibiteurs calciques, bromocriptine) ?
- Neuropathie, connectivite ?

DIFFÉRENTIELS & SIGNES DISCRIMINANTS

Érythromalgie des SMP	Forme la plus classique : thrombocyémie essentielle / Vaquez ; sensibilité spectaculaire à l'aspirine
Forme primitive/héréditaire	Mutation SCN9A, sujet jeune
Formes secondaires	Médicaments, neuropathie, connectivites

PATHOGNOMONIQUE / ORIENTATION FORTE

La sensibilité quasi immédiate à l'ASPIRINE est très évocatrice de l'érythromalgie liée à un syndrome myéloprolifératif (et constitue un test d'orientation). NFS-plaquettes systématique à la recherche d'une thrombocyémie.

△ RED FLAGS / URGENCES

- Syndrome myéloprolifératif sous-jacent (risque thrombotique)
- Thrombocyémie essentielle / maladie de Vaquez

27 Fièvre au retour d'un pays tropical

INTERROGATOIRE CIBLÉ

Le voyage

- Zone(s) visitée(s), dates, durée, délai retour-fièvre ?
- Prophylaxie antipaludique (prise, observance) ?
- Vaccinations ?

Expositions

- Piqûres de moustiques, baignade en eau douce, contacts, alimentation ?
- Rapports sexuels, soins/transfusion ?

Sémiologie

- Type de fièvre, frissons ?
- Signes digestifs, neuro, cutanés (éruption, escarre), ictère, urines foncées ?
- Signes de gravité (confusion, oligurie, purpura, détresse) ?

DIFFÉRENTIELS & SIGNES DISCRIMINANTS

Paludisme (à éliminer EN PREMIER)	Tout retour de zone d'endémie + fièvre = paludisme jusqu'à preuve du contraire → frottis/goutte épaisse en URGENCE
Arboviroses (dengue, chikungunya, Zika)	Fièvre + myalgies + éruption + thrombopénie, incubation courte
Fièvre typhoïde	Fièvre en plateau + troubles digestifs + dissociation pouls-température
Hépatites virales, amibiase, leptospirose, primo-VIH	Selon expositions

PATHOGNOMONIQUE / ORIENTATION FORTE

Aucun signe n'est pathognomonique, mais la règle absolue : toute fièvre au retour des tropiques impose d'ÉLIMINER UN PALUDISME en urgence (frottis-goutte épaisse), car le *P. falciparum* peut tuer en quelques jours. Délai d'incubation = orienteur majeur.

△ RED FLAGS / URGENCES

- Paludisme grave (neuropaludisme, défaillance d'organe)
- Fièvre hémorragique virale (isolement)
- Sepsis, purpura fébrile
- Toute fièvre + signe de gravité

INTERROGATOIRE CIBLÉ

Caractériser

- Écoulement lactescent bilatéral pluricanalaire (galactorrhée vraie) vs unilatéral uni-pore (suspect) ?
- Spontané vs provoqué ?
- Sanglant (suspect néo) ?

Hyperprolactinémie

- Aménorrhée/spanioménorrhée, infertilité, baisse de libido ?
- Céphalées, troubles visuels (adénome) ?
- Grossesse/allaitement récent ?

Causes

- Médicaments (neuroleptiques, métoclopramide, dompéridone, antidépresseurs, opiacés, vérapamil, œstrogènes) ?
- Hypothyroïdie ?
- Stimulation mammaire, stress ?

DIFFÉRENTIELS & SIGNES DISCRIMINANTS

Hyperprolactinémie médicamenteuse	Cause LA PLUS fréquente : neuroleptiques, antiémétiques dopaminergiques
Adénome à prolactine	Galactorrhée + aménorrhée + ± syndrome tumoral (céphalées, champ visuel) → IRM hypophysaire
Hypothyroïdie	TRH ↑ stimule la PRL → doser TSH
Écoulement unilatéral sanglant	ORIENTE vers pathologie canalaire/néoplasique mammaire, PAS galactorrhée

PATHOGNOMONIQUE / ORIENTATION FORTE

Galactorrhée vraie = bilatérale, pluricanalaire, lactescente. Un écoulement UNILATÉRAL, uniporal ou SANGlant n'est pas une galactorrhée et impose un bilan mammaire (cancer). Devant une hyperPRL : éliminer grossesse, médicaments et hypothyroïdie avant l'IRM.

△ RED FLAGS / URGENCES

- Écoulement unilatéral sanglant (cancer du sein)
- Macroadénome avec syndrome tumoral (champ visuel)

INTERROGATOIRE CIBLÉ

Caractériser

- Homogène/diffus vs nodulaire ?
- Vitesse d'apparition, croissance récente ?
- Signes compressifs : dysphagie, dyspnée, dysphonie, gêne cervicale ?

Dysthyroïdie

- Hyperthyroïdie : amaigrissement, tachycardie, tremblement, thermophobie, diarrhée ?
- Hypothyroïdie : frilosité, prise de poids, ralentissement, constipation ?

Terrain

- Carence iodée, ATCD familial, irradiation cervicale ?
- Nodule dur, fixé, ADP (suspicion néo) ?

DIFFÉRENTIELS & SIGNES DISCRIMINANTS

Goitre simple/multinodulaire euthyroïdien	Le plus fréquent, ancien, sans dysthyroïdie
Maladie de Basedow	Goitre diffus vasculaire (souffle/thrill) + hyperthyroïdie + orbitopathie + Ac anti-RTSH
Thyroïdite de Hashimoto	Goitre ferme + hypothyroïdie + Ac anti-TPO
Cancer thyroïdien	Nodule dur, fixé, croissance rapide, ADP, dysphonie → écho + cytoponction

PATHOGNOMONIQUE / ORIENTATION FORTE

Orbitopathie (exophtalmie) + goitre vasculaire soufflant = quasi pathognomonique de Basedow. Signes d'orientation maligne : nodule dur fixé à croissance rapide + ADP + paralysie récurrentielle → écho EU-TIRADS + cytoponction.

△ RED FLAGS / URGENCES

- Goitre compressif (dyspnée, dysphagie, dysphonie)
- Cancer (nodule dur fixé + ADP + dysphonie)
- Cardiothyroïse / crise aiguë thyrotoxique

INTERROGATOIRE CIBLÉ

Histoire de la lésion

- Apparition récente / lésion 'vilain petit canard' différente des autres ?
- Modification récente (taille, couleur, relief, saignement, prurit) ?
- ATCD personnels/familiaux de mélanome ?

Terrain

- Phototype clair, coups de soleil, expositions intenses intermittentes ?
- Nombre de nævus, nævus atypiques ?
- Immunodépression ?

DIFFÉRENTIELS & SIGNES DISCRIMINANTS

Nævus banal	Symétrique, bords réguliers, couleur homogène, stable
Mélanome	Règle ABCDE : Asymétrie, Bords irréguliers, Couleur inhomogène, Diamètre > 6 mm, Évolution
Kératose séborrhéique	Lésion 'posée', surface mate kystique (dermoscopie : pseudokystes cornés)
Carcinome basocellulaire pigmenté	Perle, télangiectasies

PATHOGNOMONIQUE / ORIENTATION FORTE

Pas de signe clinique pathognomonique du mélanome ; la dermoscopie apporte des critères (voile bleu-blanc, réseau pigmenté atypique, stries irrégulières). Le meilleur signe d'orientation reste le 'vilain petit canard' + l'ÉVOLUTIVITÉ (E de ABCDE). Au moindre doute : exérèse + histologie.

△ RED FLAGS / URGENCES

- Mélanome (toute lésion évolutive/asymétrique → exérèse)
- Saignement spontané, nodule, ulcération

31 Grosse bourse

Uro (URGENCE)

INTERROGATOIRE CIBLÉ

Aiguë vs chronique

- Douleur BRUTALE (torsion) vs progressive ?
- Âge (torsion : adolescent/jeune ; tumeur : 20-35 ans) ?
- Fièvre (orchi-épididymite) ?

Caractériser

- Augmentation de volume douloureuse vs indolore (tumeur, hydrocèle) ?
- Transillumination (hydrocèle) ?
- Traumatisme, signes urinaires/IST ?

DIFFÉRENTIELS & SIGNES DISCRIMINANTS

Torsion du cordon spermatique	Douleur brutale + testicule ascensionné/horizontalisé + abolition du réflexe crémastérien → URGENCE chirurgicale (< 6 h)
Orchi-épididymite	Douleur progressive + fièvre + signes urinaires/IST ; soulagement à la surélévation (Prehn +)
Tumeur du testicule	Masse dure indolore intratesticulaire chez l'adulte jeune → écho + marqueurs
Hydrocèle	Masse transilluminable, indolore, chronique

PATHOGNOMONIQUE / ORIENTATION FORTE

Abolition du réflexe crémastérien + testicule rétracté/horizontalisé + douleur brutale = orientation forte vers la TORSION (urgence : exploration chirurgicale sans attendre l'imagerie si doute). Masse intratesticulaire dure indolore = tumeur jusqu'à preuve du contraire.

△ RED FLAGS / URGENCES

- Torsion du cordon (urgence des 6 h)
- Tumeur testiculaire (toute masse dure indolore)
- Gangrène de Fournier (sepsis, crépitations périnéaux)

INTERROGATOIRE CIBLÉ

Caractériser

- Unilatérale, début aigu, fièvre ?
- Porte d'entrée (intertrigo, plaie, ulcère) ?
- Douleur DISPROPORTIONNÉE par rapport aux signes locaux (fasciite) ?

Signes de gravité

- Sepsis, signes généraux ?
- Bulles, nécrose, crépitation, zones hypoesthésiques/livedoïdes (fasciite nécrosante) ?
- Œdème + douleur du mollet (DD : TVP) ?

Terrain

- Diabète, immunodépression, AOMI, lymphoedème ?

DIFFÉRENTIELS & SIGNES DISCRIMINANTS

Érysipèle / dermohypodermite bactérienne	Placard inflammatoire bien limité + fièvre + porte d'entrée + ADP/traînée de lymphangite
Fasciite nécrosante	Douleur >> signes visibles, sepsis, nécrose/bulles/crépitation → URGENCE chir.
TVP	Œdème + douleur sans franc placard érysipélateux ni fièvre élevée → écho-doppler
Eczéma/dermite de stase	Bilatéral, prurit, pas de fièvre

PATHOGNOMONIQUE / ORIENTATION FORTE

Pas de pathognomonique de l'érysipèle (diagnostic clinique). SIGNAL D'ALARME majeur : une douleur DISPROPORTIONNÉE, un sepsis, des bulles/nécrose/crépitation ou un livedo = fasciite nécrosante → urgence chirurgicale, ne pas temporiser.

⚠ RED FLAGS / URGENCES

- Fasciite nécrosante (douleur disproportionnée, sepsis, nécrose)
- Sepsis sévère
- TVP associée

INTERROGATOIRE CIBLÉ

Confirmer / quantifier

- Vrai sang (vs épistaxis déglutie, hémoptysie) ?
- Hématémèse (rouge/marc de café) et/ou méléna (selles noires goudron malodorantes) ?
- Abondance, récurrence, retentissement (lipothymie, soif) ?

Étiologie

- Prise d'AINS/aspirine/anticoagulants ?
- ATCD ulcéreux, épigastralgies, RGO ?
- Alcool/hépatopathie (rupture de varices) ?
- Vomissements répétés précédant l'hématémèse (Mallory-Weiss) ?
- AEG, dysphagie (cancer) ?

Gravité

- Pâleur, tachycardie, hypoTA, marbrures (choc) ?

DIFFÉRENTIELS & SIGNES DISCRIMINANTS

Ulcère gastro- duodénal	Cause la plus fréquente ; AINS/H. pylori, épigastralgies
Rupture de varices œsophagiennes	Hépatopathie/HTP, hématémèse abondante → urgence (terlipressine, endoscopie)
Syndrome de Mallory-Weiss	Hématémèse APRÈS efforts de vomissement
Cancer gastro- œsophagien	AEG, dysphagie, anémie chronique

PATHOGNOMONIQUE / ORIENTATION FORTE

Méléna = sang digéré (origine haute, au-dessus de l'angle de Treitz le plus souvent). Hématémèse précédée de vomissements alimentaires répétés = oriente vers Mallory-Weiss. Hépatopathie connue + hématémèse abondante = varices. La PRIORITÉ est hémodynamique avant l'étiologie.

⚠ RED FLAGS / URGENCES

- Choc hémorragique
- Rupture de varices (cirrrose)
- Récidive hémorragique
- Anticoagulation associée

INTERROGATOIRE CIBLÉ

Confirmer / caractériser

- Macroscopique vs microscopique (BU/ECBU) ?
- Chronologie : initiale (uréthro-prostatique), terminale (vésicale), totale (rénale/diffuse) ?
- Caillots (origine urologique) ?
- Indolore (alarme néo) vs douloureuse (lithiase, infection) ?

Orientation

- Tabac, exposition pro (cancer urothélial) ?
- Signes irritatifs, fièvre (cystite, prostatite) ?
- Colique néphrétique (lithiase) ?
- Œdèmes, HTA, protéinurie (glomérulopathie) ?
- Anticoagulants (révélateurs, n'expliquent pas tout) ?

DIFFÉRENTIELS & SIGNES DISCRIMINANTS

Tumeur urothéliale/rénale	Hématurie macro INDOLORE, fumeur > 50 ans → cystoscopie + uro-TDM
Lithiase	Hématurie + colique néphrétique
Infection	Hématurie + signes irritatifs + fièvre + ECBU+
Glomérulonéphrite	Hématurie + protéinurie + HTA + cylindres hématiques → néphro

PATHOGNOMONIQUE / ORIENTATION FORTE

Hématurie macroscopique INDOLORE = cancer urologique jusqu'à preuve du contraire (surtout fumeur > 50 ans) → bilan complet même si épisode unique. Hématurie + protéinurie + cylindres hématiques = origine glomérulaire (néphrologique). La chronologie (initiale/terminale/totale) localise.

⚠ RED FLAGS / URGENCES

- Cancer urothélial/rénal (hématurie indolore)
- Hématurie + caillots avec rétention
- Glomérulonéphrite rapidement progressive (HTA, IRA)

INTERROGATOIRE CIBLÉ

Confirmer

- Vraiment du sang craché à l'effort de toux (vs hématomèse, saignement ORL) ?
- Sang rouge aéré spumeux ?
- Abondance (quantifier en mL/24h : la gravité = abondance + terrain respiratoire) ?

Étiologie

- Tabac, AEG, hémoptysie persistante (cancer bronchique) ?
- Fièvre, expectoration (pneumopathie, DDB, TB) ?
- Contexte thrombo-embolique (EP avec infarctus) ?
- ATCD cardiaque (OAP, RM) ?
- Anticoagulants ?

DIFFÉRENTIELS & SIGNES DISCRIMINANTS

Cancer bronchique	Hémoptysie + tabac + AEG → fibroscopie + TDM
Tuberculose	Hémoptysie + AEG + sueurs nocturnes + contagé
Dilatation des bronches	Hémoptysies répétées + bronchorrhée chronique
Embolie pulmonaire	Hémoptysie + douleur pleurale + dyspnée + contexte
Causes cardiaques	Rétrécissement mitral, OAP

PATHOGNOMONIQUE / ORIENTATION FORTE

Pas de pathognomonie étiologique. La GRAVITÉ prime : une hémoptysie de grande abondance ou sur poumon pathologique menace par asphyxie (pas par l'hémorragie). Toute hémoptysie chez un fumeur impose une endoscopie + TDM (cancer). Goutte de sang rouge aéré spumeux = origine bronchique vraie.

⚠ RED FLAGS / URGENCES

- Hémoptysie de grande abondance (asphyxie)
- Cancer bronchique
- Tuberculose active (contagiosité)
- Détresse respiratoire

INTERROGATOIRE CIBLÉ

Caractériser

- Sang dans le sperme, isolé ?
- Épisode unique vs récurrent ?
- Âge (< 40 ans : souvent bénin ; > 40 ans : explorer) ?
- Hémospémie + hématurie (origine urinaire) ?

Étiologie

- Geste récent (biopsie prostatique, vasectomie) ?
- Signes infectieux (prostatite, urétrite/IST) ?
- ATCD ou signes de cancer prostatique (TR, PSA) ?
- Trouble de l'hémostase, HTA ?

DIFFÉRENTIELS & SIGNES DISCRIMINANTS

Hémospémie idiopathique/bénigne	Sujet jeune, isolée, transitoire, rassurante
Infection (prostatite, vésiculite, IST)	Contexte infectieux, brûlures
Cause prostatique (> 40 ans)	Adénome, cancer → TR + PSA
Post-geste	Biopsie prostatique récente (banal)

PATHOGNOMONIQUE / ORIENTATION FORTE

Pas de pathognomonique. Orientation par l'âge : chez le sujet jeune, isolée et transitoire = bénigne (rassurer) ; après 40 ans ou récurrente = bilan (TR, PSA, écho, ECU) pour ne pas méconnaître une cause prostatique.

△ RED FLAGS / URGENCES

- Cancer de la prostate (> 40 ans, hémospémie persistante)
- Hémospémie + hématurie (cause urologique)

37 Hépatomégalie

INTERROGATOIRE CIBLÉ

Caractériser le foie

- Bord (tranchant régulier vs mousse), consistance (dur = cirrhose/néo, ferme régulier = stase) ?
- Surface (nodulaire = cirrhose/métastases) ?
- Douleur (foie cardiaque, abcès, tumeur) ?
- Reflux hépato-jugulaire (foie cardiaque) ?

Contexte

- Alcool, hépatite virale, surcharge, médicaments hépatotoxiques (paracétamol, méthotrexate) ?
- ATCD néoplasique (métastases) ?
- Insuffisance cardiaque droite ?
- Ictère, prurit, signes d'hypertension portale ?

DIFFÉRENTIELS & SIGNES DISCRIMINANTS

Foie de cirrhose	Dur, bord tranchant, surface irrégulière + signes d'HTP/IHC
Foie cardiaque	Ferme, douloureux, reflux hépato-jugulaire, expansif (RT)
Foie tumoral (métastases, CHC)	Dur, nodulaire, parfois douloureux, AEG
Stéatose	Foie ferme régulier, contexte métabolique/alcool

PATHOGNOMONIQUE / ORIENTATION FORTE

Pas de pathognomonique. Discriminants palpatoires : bord tranchant + surface irrégulière + signes d'HTP = cirrhose ; foie douloureux expansif + reflux hépato-jugulaire = foie cardiaque ; gros foie dur nodulaire + AEG = tumoral.

△ RED FLAGS / URGENCES

- CHC / métastases
- Hépatite fulminante (ictère + encéphalopathie + TP↓)
- Foie cardiaque (insuffisance cardiaque droite)

INTERROGATOIRE CIBLÉ

Caractériser

- > 48 h (chronique) ?
- Permanent (y compris la nuit → organique) vs intermittent ?
- Retentissement (sommeil, alimentation, amaigrissement) ?

Étiologie (sur le trajet du nerf phrénique/vague)

- Digestif : RGO, ulcère, distension gastrique, pathologie sous-phrénique ?
- Médiastinal/thoracique : tumeur, péricardite ?
- Neuro central : AVC, tumeur, SEP du tronc ?
- Métabolique : urémie, hyponatrémie, hypocalcémie ?
- Médicaments (corticoïdes, benzodiazépines) ?

DIFFÉRENTIELS & SIGNES DISCRIMINANTS

Hoquet digestif	RGO, distension gastrique, irritation diaphragmatique sous-phrénique
Hoquet central	Lésion du tronc/bulbe (AVC, tumeur, SEP) → IRM si signes neuro
Hoquet métabolique/iatrogène	Urémie, dysnatrémie, corticoïdes
Hoquet tumoral médiastinal	Irritation phrénique

PATHOGNOMONIQUE / ORIENTATION FORTE

Pas de pathognomonique. Orientation : un hoquet qui PERSISTE pendant le sommeil est organique (vs psychogène qui cède la nuit). Un hoquet chronique rebelle impose d'explorer tout le trajet phréno-vagal (du tronc cérébral à l'abdomen).

△ RED FLAGS / URGENCES

- Cause centrale (AVC/tumeur du tronc)
- Cause métabolique (urémie)
- Néoplasie thoracique/sous-phrénique

39 Hyperhidroses

INTERROGATOIRE CIBLÉ

Caractériser

- Localisée (palmo-plantaire, axillaire = primaire) vs généralisée (secondaire) ?
- Diurne déclenchée par l'émotion (primaire) vs nocturne (secondaire) ?
- Symétrique ?

Sueurs secondaires : drapeaux

- Sueurs NOCTURNES + fièvre + amaigrissement (TB, lymphome, néo) ?
- Thermophobie, tachycardie, amaigrissement (hyperthyroïdie) ?
- Triade céphalées-palpitations + HTA paroxystique (phéochromocytome) ?
- Bouffées de la ménopause ?
- Hypoglycémies, médicaments/sevrage (alcool, opiacés, antidépresseurs) ?

DIFFÉRENTIELS & SIGNES DISCRIMINANTS

Hyperhidrose primaire (essentielle)	Localisée, symétrique, débute jeune, déclenchée par l'émotion, pas la nuit
Sueurs nocturnes 'B'	Lymphome, tuberculose, néoplasie → bilan
Hyperthyroïdie	Sueurs + thermophobie + amaigrissement + tachycardie
Phéochromocytome	Sueurs + triade + HTA paroxystique

PATHOGNOMONIQUE / ORIENTATION FORTE

Distinction clé à l'interrogatoire : hyperhidrose primaire = localisée, symétrique, diurne, émotionnelle, JAMAIS nocturne. Des sueurs NOCTURNES profuses + signes généraux (fièvre, amaigrissement) = secondaires et imposent un bilan (lymphome, TB, néo).

△ RED FLAGS / URGENCES

- Sueurs nocturnes + AEG (lymphome, TB, néoplasie)
- Phéochromocytome (HTA paroxystique)
- Cardiothyroïse

INTERROGATOIRE CIBLÉ

Caractériser

- Aspect : blanc grumeleux (candidose), gris homogène malodorant 'poisson' (vaginose), verdâtre spumeux (trichomonas) ?
- Prurit/brûlure (mycose) vs odeur (vaginose) ?
- Dyspareunie, signes urinaires ?

Contexte

- Rapports, partenaires, IST ?
- ATB récents, grossesse, diabète, corticoïdes (candidose) ?
- Douleurs pelviennes + fièvre (salpingite haute) ?

DIFFÉRENTIELS & SIGNES DISCRIMINANTS

Candidose	Leucorrhées blanches caillottées + prurit intense + vulve érythémateuse ; pH < 4,5
Vaginose bactérienne	Leucorrhées grises homogènes + odeur de poisson (test à la potasse +) ; pH > 4,5
Trichomonase (IST)	Leucorrhées verdâtres spumeuses + colpite punctiforme + prurit
Cervicite (Chlamydia/gono)	Leucorrhées + cervicite + risque d'extension haute

PATHOGNOMONIQUE / ORIENTATION FORTE

Odeur de poisson amplifiée par la potasse (sniff-test +) + pH > 4,5 = vaginose bactérienne. Leucorrhées caillottées + prurit + pH acide = candidose. Colpite 'piqueté framboise' = trichomonase. Toujours évoquer une IST si facteur de risque (dépistage Chlamydia/gono).

△ RED FLAGS / URGENCES

- Salpingite (leucorrhées + douleurs + fièvre)
- IST avec atteinte haute / risque d'infertilité

- Grossesse (vaginose = risque d'accouchement prématuré)

INTERROGATOIRE CIBLÉ

Mécanique vs inflammatoire

- Horaire mécanique (effort, soir, repos améliore) vs inflammatoire (2e partie de nuit, dérouillage > 30 min) ?
- Effort/port de charge déclenchant ?
- Raideur, position antalgique ?

Drapeaux rouges (red flags)

- Âge < 20 / > 55 ans (1er épisode) ?
- AEG, fièvre, ATCD néoplasique ?
- Douleur non mécanique, permanente, nocturne ?
- Déficit neuro, troubles sphinctériens, anesthésie en selle (syndrome de la queue de cheval) ?
- Traumatisme, corticothérapie, ostéoporose (fracture) ?

Radiculalgie

- Sciatique (L5/S1) ou cruralgie (L3/L4), trajet, Lasèque ?

DIFFÉRENTIELS & SIGNES DISCRIMINANTS

Lombalgie commune	Mécanique, sans drapeau rouge, > 90 % des cas, pas d'imagerie d'emblée
Lombosciatique discale	Douleur radiculaire systématisée + Lasèque +
Lombalgie symptomatique	Inflammatoire + drapeaux → spondylodiscite, tumeur/métastase, myélome, fracture
Syndrome de la queue de cheval	Anesthésie en selle + troubles sphinctériens + déficit → URGENCE chirurgicale

PATHOGNOMONIQUE / ORIENTATION FORTE

Pas de pathognomonique de la lombalgie commune (diagnostic clinique d'élimination des drapeaux rouges). URGENCE à ne jamais manquer : syndrome de la queue de cheval (anesthésie en selle + rétention/incontinence + déficit bilatéral) → IRM et décompression en urgence.

△ RED FLAGS / URGENCES

- Syndrome de la queue de cheval
- Spondylodiscite (fièvre + lombalgie inflammatoire)

- Métastase/myélome/fracture (AEG, ostéoporose, ATCD néo)
- Déficit moteur radiculaire progressif

INTERROGATOIRE CIBLÉ

Caractériser l'épisode (témoin ++)

- Vraie perte de connaissance (PC) vs malaise sans PC ?
- Prodromes (sueurs, voile, nausées = vagal) ou aucun (cardiaque, syncope d'effort) ?
- Circonstances : effort (cardiaque grave), orthostatisme, émotion, miction/toux ?
- Durée, récupération (immédiate = syncope vs confusion post-critique = épilepsie) ?

Syncope vs crise

- Mouvements cloniques, morsure latérale de langue, perte d'urine, phase post-critique (épilepsie) ?
- Pâleur + retour rapide à la conscience (syncope) ?

Étiologie cardiaque (à éliminer)

- Palpitations, douleur thoracique, dyspnée ?
- Syncope À L'EFFORT ou en décubitus (alarme : RAo, CMH, trouble du rythme) ?
- ATCD cardiaque, mort subite familiale ?
- Médicaments (antiHTA, allongeurs du QT, hypoglycémiant) ?

DIFFÉRENTIELS & SIGNES DISCRIMINANTS

Syncope vagale	Prodromes neurovégétatifs + facteur déclenchant + récupération rapide ; bénigne
Syncope cardiaque	À l'effort/sans prodrome, sur cardiopathie → grave (rythmique, RAo, CMH, EP) → ECG indispensable
Hypotension orthostatique	Au lever, iatrogène/dysautonomie ; chute TA debout
Crise d'épilepsie	Morsure latérale de langue + confusion post-critique + mouvements

PATHOGNOMONIQUE / ORIENTATION FORTE

Pas de pathognomonique unique. Discriminants forts : morsure LATÉRALE de langue + confusion post-critique = épilepsie ; prodromes végétatifs + récupération immédiate = vagal. SIGNAL D'ALARME : syncope à l'EFFORT ou sans prodrome chez un cardiaque = cause rythmique/obstructive (risque de mort subite) → ECG systématique.

▲ RED FLAGS / URGENCES

- Syncope d'effort / sans prodrome (cardiaque, mort subite)
- ECG : QT long, BAV, pré-excitation, Brugada
- Cardiopathie sous-jacente (RAo, CMH)
- Embolie pulmonaire (syncope + dyspnée)

43 Allongement du temps de saignement (TS) / hémostasie primaire

INTERROGATOIRE CIBLÉ

Saignement clinique

- Saignements cutané-muqueux (purpura, épistaxis, gingivorragies, ménorragies) = hémostasie primaire ?
- Spontané vs provoqué, ancienneté (constitutionnel vs acquis) ?

Étiologie

- Médicaments antiplaquettaires (aspirine, AINS, clopidogrel) ?
- Thrombopénie connue ?
- Insuffisance rénale (urémie), dysglobulinémie ?
- ATCD familial (Willebrand : la maladie hémorragique constitutionnelle la plus fréquente) ?

DIFFÉRENTIELS & SIGNES DISCRIMINANTS

Thrombopénie	Plaquettes basses (la 1re cause à éliminer : NFS)
Maladie de Willebrand	Saignements muqueux + ATCD familial + TCA parfois allongé
Thrombopathie médicamenteuse	Aspirine/AINS/antiagrégants
Thrombopathies acquises	Urémie, dysglobulinémie, syndrome myéloprolifératif

PATHOGNOMONIQUE / ORIENTATION FORTE

Le saignement de TYPE hémostasie primaire = cutané-muqueux (purpura pétéchial, épistaxis, ménorragies), à différencier des hématomes/hémarthroses (coagulation). Devant un TS allongé : d'abord éliminer une thrombopénie (NFS) et les antiagrégants, puis évoquer Willebrand.

▲ RED FLAGS / URGENCES

- Thrombopénie profonde (risque hémorragique)
- Saignement actif sous antiagrégants

INTERROGATOIRE CIBLÉ

Contexte

- Syndrome hémorragique (déficit en facteur) vs thrombotique/asymptomatique (anticoagulant circulant) ?
- Héparinothérapie en cours (cause n°1 d'allongement isolé) ?
- ATCD familial hémorragique (hémophilie A/B chez le garçon) ?
- ATCD thrombotique, fausses couches (SAPL) ?

DIFFÉRENTIELS & SIGNES DISCRIMINANTS

Héparine	Cause la plus fréquente d'allongement isolé du TCA
Hémophilie A (VIII) / B (IX)	Garçon, hémarthroses/hématomes, TCA allongé + TP normal
Maladie de Willebrand	TCA $\pm$ allongé (baisse du VIII)
Anticoagulant circulant (anti-VIII, lupique/SAPL)	TCA allongé non corrigé par le plasma témoin $\rightarrow$ thrombose, pas hémorragie

PATHOGNOMONIQUE / ORIENTATION FORTE

Le test de correction (mélange plasma malade + témoin) est l'orientation clé : CORRIGE = déficit en facteur (hémophilie, Willebrand) ; NE CORRIGE PAS = anticoagulant circulant (anti-VIII ou antiphospholipide). Toujours éliminer l'héparine d'abord.

⚠ RED FLAGS / URGENCES

- Hémophilie sévère (saignement)
- SAPL (risque thrombotique malgré TCA allongé)

45 Allongement du TP / temps de Quick (TP bas)

INTERROGATOIRE CIBLÉ

Contexte

- Traitement par AVK (cause la plus fréquente : surveiller l'INR) ?
- Hépatopathie (insuffisance hépatocellulaire) ?
- Ictère cholestatique / malabsorption (carence en vitamine K) ?
- Saignement, contexte de CIVD (sepsis, obstétrical) ?
- Nouveau-né, dénutrition, antibiothérapie prolongée ?

DIFFÉRENTIELS & SIGNES DISCRIMINANTS

AVK	Allongement attendu/recherché (INR)
Insuffisance hépatocellulaire	TP bas + facteur V BAS (différencie de la carence en vit. K)
Carence en vitamine K	TP bas + facteur V NORMAL (cholestase, malabsorption, antibiothérapie) ; corrigé par vit. K
CIVD	TP bas + plaquettes $\downarrow$ + fibrinogène $\downarrow$ + D-dimères $\uparrow$

PATHOGNOMONIQUE / ORIENTATION FORTE

Le FACTEUR V est le discriminant majeur : V bas = insuffisance hépatocellulaire ; V normal = carence en vitamine K (cholestase/malabsorption, corrigeable par la vit. K). Association TP $\downarrow$ + plaquettes $\downarrow$ + fibrinogène $\downarrow$ = CIVD.

⚠ RED FLAGS / URGENCES

- Insuffisance hépatique aiguë (TP < 50 %, facteur V effondré)
- CIVD
- Surdosage AVK avec hémorragie

INTERROGATOIRE CIBLÉ

Contexte

- Héparine (cause la plus fréquente) ?
- Hépatopathie, CIVD (anomalie du fibrinogène) ?
- Dysglobulinémie ?
- Traitement thrombolytique ?

DIFFÉRENTIELS & SIGNES DISCRIMINANTS

Héparine / contamination héparine	Allonge le TT (neutralisé par la protamine)
Hypo/ dysfibrinogénémie	Constitutionnelle ou acquise (IHC, CIVD)
Présence d'inhibiteurs	Dysglobuline, PDF élevés

PATHOGNOMONIQUE / ORIENTATION FORTE

Le TT explore la dernière étape (fibrinogène → fibrine). Allongement isolé = héparine (le plus souvent) ou anomalie quantitative/qualitative du fibrinogène. Doser le fibrinogène pour trancher.

⚠ RED FLAGS / URGENCES

- CIVD avec consommation du fibrinogène
- Hépatopathie sévère

47 Anomalie héréditaire de l'hémostase

INTERROGATOIRE CIBLÉ

Type de saignement

- Cutanéomuqueux (Willebrand, thrombopathie) vs hématomes/hémarthroses (hémophilie) ?
- Dès l'enfance, à l'occasion de gestes (circoncision, chute, extraction dentaire) ?

Enquête familiale (capitale)

- Arbre généalogique : transmission liée à l'X (hémophilie, garçons) vs autosomique (Willebrand) ?
- Apparentés atteints, consanguinité ?

Thrombophilie héréditaire

- ATCD thrombotiques familiaux/personnels précoces, fausses couches répétées (facteur V Leiden, déficit en AT/PC/PS) ?

DIFFÉRENTIELS & SIGNES DISCRIMINANTS

Maladie de Willebrand	La plus fréquente, autosomique, saignements muqueux
Hémophilie A/B	Liée à l'X, garçons, hémarthroses
Thrombophilies constitutionnelles	Facteur V Leiden, mutation II, déficits AT/PC/PS → versant thrombotique

PATHOGNOMONIQUE / ORIENTATION FORTE

L'arbre généalogique et le TYPE de saignement orientent : hémarthroses chez un garçon avec transmission liée à l'X = hémophilie ; saignements muqueux autosomiques = Willebrand. Pour la thrombophilie, ce sont les ATCD thrombotiques précoces/familiaux et les fausses couches qui orientent.

⚠ RED FLAGS / URGENCES

- Hémophilie sévère (hémarthroses invalidantes)
- Thrombophilie majeure (récidive thrombo-embolique)

INTERROGATOIRE CIBLÉ

Devant un pic (gammopathie)

- Douleurs osseuses, fractures, tassements (myélome) ?
- AEG, anémie, insuffisance rénale, hypercalcémie (myélome) ?
- ADP, splénomégalie (Waldenström, LLC) ?
- Infections répétées ?

Devant une hypogammaglobulinémie

- Infections à répétition, diarrhée, déficit immunitaire ?

Devant un bloc β - γ / hypoalbuminémie

- Hépatopathie (bloc β - γ) ? Syndrome néphrotique / inflammation (albumine basse) ?

DIFFÉRENTIELS & SIGNES DISCRIMINANTS

Pic monoclonal étroit (gamma)	Myélome, MGUS, Waldenström (IgM) → immunofixation, CLL, protéinurie de Bence-Jones
Hypergammaglobulinémie polyclonale	Inflammation chronique, hépatopathie, infections, maladies auto-immunes
Bloc bêta-gamma	Cirrhose
Hypogammaglobulinémie	Déficit immunitaire, fuite (néphrotique), myélome à chaînes légères

PATHOGNOMONIQUE / ORIENTATION FORTE

Un pic ÉTROIT à base étroite dans les gamma = composant MONOCLONAL (immunofixation pour le typer) → myélome/MGUS/Waldenström. Une élévation polyclonale 'en dôme' = réactionnelle (inflammation/hépatopathie). Le bloc β - γ est très évocateur de cirrhose.

△ RED FLAGS / URGENCES

- Myélome (CRAB : hyperCalcémie, Rénale, Anémie, Bone/os)
- Amylose AL
- Waldenström symptomatique

49 Hyperéosinophilie

INTERROGATOIRE CIBLÉ

Médicaments (1re cause en France)

- Tout médicament récent (β -lactamines, AINS, antiépileptiques, allopurinol...) ? DRESS ?

Parasitose (2e cause)

- Voyage tropical, helminthiase (cycle tissulaire) ?
- Troubles digestifs, prurit ?

Atopie

- Asthme, rhinite, eczéma, urticaire ?

Causes systémiques

- AEG, fièvre, signes de vascularite (Churg-Strauss : asthme + éosinophilie), néoplasie, hémopathie ?

DIFFÉRENTIELS & SIGNES DISCRIMINANTS

Hyperéosinophilie médicamenteuse	La plus fréquente ; penser DRESS si fièvre + éruption + atteinte viscérale
Parasitoses helminthiques	Selon le voyage et le cycle (phase d'invasion)
Atopie	Contexte allergique
Causes systémiques/malignes	Vascularite à ANCA (Churg-Strauss), lymphome, SHE, néoplasie

PATHOGNOMONIQUE / ORIENTATION FORTE

Pas de pathognomonique. Démarche d'orientation : 'médicament, parasite, atopie' couvre l'immense majorité. Une hyperéosinophilie franche + asthme + atteinte multisystémique = granulomatose éosinophilique avec polyangéite. Éosinophilie + fièvre + DRESS = urgence d'arrêt du médicament.

△ RED FLAGS / URGENCES

- DRESS (atteinte viscérale)
- Syndrome hyperéosinophilique (atteinte cardiaque)
- Vascularite (Churg-Strauss)
- Angiulose maligne avant immunosuppression

INTERROGATOIRE CIBLÉ

Contexte

- Syndrome viral, infection en cours ?
- ADP, splénomégalie, angine traînante (MNI) ?
- AEG, signes d'hémopathie (anémie, syndrome hémorragique, infections) ?
- Médicaments, terrain ?

DIFFÉRENTIELS & SIGNES DISCRIMINANTS

Lymphocytose réactionnelle virale	Enfant/adulte jeune, syndrome viral, MNI (syndrome mononucléosique)
Syndrome lymphoprolifératif	Sujet âgé : hyperlymphocytose persistante → immunophénotypage (LLC)
Coqueluche	Hyperlymphocytose + toux quinteuse
Neutropénie associée	Selon le mécanisme

PATHOGNOMONIQUE / ORIENTATION FORTE

L'inversion (lymphocytes > neutrophiles) est physiologique chez le jeune enfant. Chez l'adulte : une hyperlymphocytose persistante (> 1 mois) impose un immunophénotypage (LLC). Un syndrome mononucléosique oriente vers MNI/CMV/toxoplasmose/primo-VIH.

⚠ RED FLAGS / URGENCES

- Leucémie aiguë (cytopénies + blastes)
- LLC à fort compte / syndrome de Richter

- Primo-infection VIH (à ne pas manquer)

51 Hyperglycémie de l'adulte

INTERROGATOIRE CIBLÉ

Affirmer le diabète

- Polyurie, polydipsie, amaigrissement (syndrome cardinal) ?
- Glycémie à jeun $\geq 1,26$ g/L ($\times 2$) / HbA1c / glycémie ≥ 2 g/L + symptômes ?

Type 1 vs 2

- Sujet jeune, maigre, début rapide, cétose (type 1) vs surpoids, syndrome métabolique, > 40 ans (type 2) ?

Gravité / complications

- Signes de cétose (nausées, dyspnée, haleine acétonique) ?
- Déshydratation, troubles de conscience (coma hyperosmolaire) ?
- Facteur déclenchant (infection, corticoïdes) ?

Secondaire

- Corticoïdes, pancréatopathie, hémochromatose, endocrinopathie (Cushing, acromégalie) ?

DIFFÉRENTIELS & SIGNES DISCRIMINANTS

Diabète de type 2	Surpoids, insulino-résistance, > 40 ans, asymptomatique souvent
Diabète de type 1	Jeune, maigre, syndrome cardinal rapide, cétose, auto-Ac
Acidocétose / coma hyperosmolaire	Urgences métaboliques (cétose vs déshydratation majeure)
Diabète secondaire	Iatrogène (corticoïdes), pancréatique, endocrinien

PATHOGNOMONIQUE / ORIENTATION FORTE

Le syndrome cardinal (polyuro-polydipsie + amaigrissement) rapide chez un sujet jeune et maigre = type 1 avec risque de cétose (urgence). Haleine acétonique + dyspnée de Kussmaul = acidocétose. Le diagnostic positif est biologique (seuils OMS).

⚠ RED FLAGS / URGENCES

- Acidocétose diabétique
- Coma hyperosmolaire

- Hyperglycémie + infection/sepsis

INTERROGATOIRE CIBLÉ

Symptômes (souvent vers 3 mmol/L)

- 'Pierres, os, abdomen, psyché' : lithiase, douleurs osseuses, douleurs abdo/constipation/nausées, troubles psychiques ?
- Polyuro-polydipsie, déshydratation ?

Les 2 grandes causes (90 %)

- Signes d'hyperparathyroïdie primaire (souvent asymptomatique, fortuite) ?
- Néoplasie connue, AEG, métastases osseuses, myélome (hypercalcémie maligne) ?

Autres

- Vitamine D/calcium, diurétiques thiazidiques, lithium ?
- Sarcoïdose, immobilisation, hyperthyroïdie ?

DIFFÉRENTIELS & SIGNES DISCRIMINANTS

Hyperparathyroïdie primaire	PTH normale-haute ou élevée (inadaptée), calcémie modérément élevée, fortuite
Hypercalcémie maligne	PTH BASSE (freinée) + néoplasie (métastases, myélome, PTHrp)
Iatrogène	Vit. D, thiazidiques, lithium, syndrome des buveurs de lait
Granulomatose	Sarcoïdose (calcitriol ↑)

PATHOGNOMONIQUE / ORIENTATION FORTE

La PTH tranche : PTH élevée/inadaptée = hyperparathyroïdie primaire ; PTH FREINÉE = cause non parathyroïdienne (néoplasie surtout). HyperPTH primaire (fortuite, modérée) et cancer (contexte d'AEG, sévère) = 90 % des causes.

▲ RED FLAGS / URGENCES

- Hypercalcémie maligne aiguë (> 3,5 mmol/L : troubles du rythme, coma)
- Néoplasie sous-jacente
- Insuffisance rénale, déshydratation

INTERROGATOIRE CIBLÉ

Éliminer une fausse hyperkaliémie

- Garrot prolongé, hémolyse du prélèvement, thrombocytose/hyperleucocytose ?

Mécanismes / causes

- Insuffisance rénale (cause majeure) ?
- Médicaments hyperkaliémisants (IEC/ARA2, diurétiques épargneurs de K⁺ - spironolactone/amiloride, AINS, héparine, triméthoprim) ?
- Acidose, rhabdomyolyse, lyse tumorale, hémolyse ?
- Insuffisance surrénale (Addison) ?

Gravité

- Signes neuromusculaires (paresthésies, paralysie) ?
- ECG : ondes T amples/pointues, élargissement QRS, bradycardie ?

DIFFÉRENTIELS & SIGNES DISCRIMINANTS

Hyperkaliémie iatrogène	Très fréquente : association IEC/ARA2 + épargneur potassique + AINS ± IR
Insuffisance rénale	Défaut d'excrétion
Transfert / lyse cellulaire	Acidose, rhabdomyolyse, lyse tumorale, hémolyse
Hypoaldostéronisme	Addison, hyporéninisme du diabétique

PATHOGNOMONIQUE / ORIENTATION FORTE

Toujours éliminer la fausse hyperkaliémie (hémolyse de prélèvement) avant d'agir. Le danger est CARDIAQUE et non corrélé aux symptômes : l'ECG (ondes T amples, élargissement du QRS, bradycardie) guide l'urgence. Cause la plus fréquente en ville = iatrogène (bloqueurs du SRAA) ± insuffisance rénale.

▲ RED FLAGS / URGENCES

- Hyperkaliémie menaçante (ECG modifié) = URGENCE (gluconate de Ca, etc.)
- QRS élargis / bradycardie (risque d'arrêt)
- Insuffisance rénale aiguë

INTERROGATOIRE CIBLÉ

Pertes

- Digestives : diarrhée, vomissements, laxatifs ?
- Rénales : diurétiques (thiazidiques, anse), hyperaldostéronisme, hypomagnésémie ?

Transfert

- Alcalose, insuline, $\beta 2$ -mimétiques, reféeding ?

HTA associée

- HTA + hypokaliémie → hyperaldostéronisme (Conn), HTA rénovasculaire, Cushing ?

Gravité

- Crampes, faiblesse musculaire, paralysie, iléus ?
- ECG : ondes U, aplatissement de T, troubles du rythme (surtout si digitaliques) ?

DIFFÉRENTIELS & SIGNES DISCRIMINANTS

Pertes digestives	Diarrhée/vomissements/laxatifs (chlorurie basse si vomissements)
Pertes rénales iatrogènes	Diurétiques hypokaliémiant (cause n°1)
Hyperaldostéronisme	HTA + hypokaliémie + kaliurèse inadaptée → Conn/HTA secondaire
Transfert	Alcalose, $\beta 2$ -mimétiques, insuline

PATHOGNOMONIQUE / ORIENTATION FORTE

L'association HTA + hypokaliémie est une orientation forte vers un hyperaldostéronisme (adénome de Conn) ou une autre HTA endocrine. Risque majeur : troubles du rythme, surtout en cas de traitement DIGITALIQUE (la déplétion potassique majore la toxicité de la digoxine).

⚠ RED FLAGS / URGENCES

- Troubles du rythme (potentialisés par digitaliques)
- Hypokaliémie profonde < 2,5 (paralysie, rhabdomyolyse)
- Torsades de pointes (si QT long associé)

INTERROGATOIRE CIBLÉ

Éliminer les fausses

- Hyperglycémie/mannitol (hypertonique), hyperprotidémie/hyperlipidémie (fausse) ?

Évaluer la volémie (clé)

- Hypovolémie : déshydratation, pli cutané, pertes digestives/rénale/diurétiques ?
- Hypervolémie : œdèmes (IC, cirrhose, néphrotique) ?
- Euvolémie : SIADH (médicaments, cancer, pneumopathie, pathologie SNC), hypothyroïdie, insuffisance surrénale, potomanie ?

Médicaments

- Diurétiques (thiazidiques ++), ISRS, carbamazépine, antipsychotiques ?

Gravité / rapidité

- Installation aiguë ? Troubles neuro (confusion, convulsions, coma) ?

DIFFÉRENTIELS & SIGNES DISCRIMINANTS

Hyponatrémie hypovolémique	Pertes (digestives, diurétiques, surrénale) avec déshydratation extracellulaire
Hyponatrémie hypervolémique	IC, cirrhose, syndrome néphrotique (hyperhydratation globale)
SIADH (euvolémique)	Natriurèse conservée, osmolalité U inadaptée ; cancers, médicaments, SNC, poumon
Endocrinien	Hypothyroïdie, insuffisance surrénale

PATHOGNOMONIQUE / ORIENTATION FORTE

Pas de pathognomonique : la démarche repose sur l'évaluation de la VOLÉMIE + osmolalités sang/urines. Le SIADH est euvolémique avec urines inadaptées concentrées. Le DANGER neurologique dépend de la RAPIDITÉ d'installation ; la correction doit être lente (risque de myélinolyse centro-pontine si trop rapide).

⚠ RED FLAGS / URGENCES

- Hyponatrémie aiguë symptomatique (convulsions, coma)
- Correction trop rapide (myélinolyse centro-pontine)
- Insuffisance surrénale aiguë méconnue

INTERROGATOIRE CIBLÉ

Cause principale

- Insuffisance rénale chronique (cause n°1) ?

Apports / relargage

- Apports excessifs (laxatifs/lavements phosphatés, vit. D) ?
- Lyse cellulaire : lyse tumorale, rhabdomyolyse, hémolyse ?

Endocrinien

- Hypoparathyroïdie (PTH basse) ? Acromégalie ?

Signes d'hypocalcémie associée

- Paresthésies, tétanie (Chvostek/Trousseau) ?

DIFFÉRENTIELS & SIGNES DISCRIMINANTS

Insuffisance rénale	Défaut d'excrétion, contexte d'IRC ; couple Ca/P et PTH
Lyse cellulaire	Lyse tumorale (+ hyperuricémie + hyperK + hypoCa), rhabdomyolyse
Hypoparathyroïdie	P haut + Ca bas + PTH basse
Apports / vitamine D excessive	Iatrogène

PATHOGNOMONIQUE / ORIENTATION FORTE

L'insuffisance rénale est la cause de loin la plus fréquente. Une hyperphosphorémie aiguë + hypocalcémie + hyperkaliémie + hyperuricémie = syndrome de lyse tumorale (urgence). Le couple Ca/P et la PTH orientent les causes endocriniennes.

△ RED FLAGS / URGENCES

- Syndrome de lyse tumorale
- Hypocalcémie symptomatique associée
- Calcifications métastatiques (produit $Ca \times P$ élevé)

57 Hyperprolactinémie

INTERROGATOIRE CIBLÉ

Éliminer les causes 'physiologiques'/erreurs

- Grossesse, allaitement, stress du prélèvement, effort ?

Médicaments (cause fréquente)

- Neuroleptiques, métoclopramide, dompéridone, antidépresseurs, opiacés, vérapamil, œstrogènes ?

Signes d'adénome

- Galactorrhée, aménorrhée/troubles du cycle, infertilité, baisse de libido/DE ?
- Syndrome tumoral : céphalées, anomalie du champ visuel (hémianopsie bitemporale) ?

Autres

- Hypothyroïdie (TRH ↑) ? Insuffisance rénale ? Compression de la tige ?

DIFFÉRENTIELS & SIGNES DISCRIMINANTS

Hyperprolactinémie médicamenteuse	Très fréquente : psychotropes, antiémétiques dopaminergiques
Adénome à prolactine	Micro/macroadénome → IRM hypophysaire ; PRL souvent très élevée si macro
Hypothyroïdie	TSH systématique
Déconnexion hypothalamo-hypophysaire	Macroadénome non sécrétant comprimant la tige (PRL modérément ↑)

PATHOGNOMONIQUE / ORIENTATION FORTE

Avant l'IRM, éliminer les 3 'faux coupables' : grossesse, médicaments, hypothyroïdie. Une PRL très élevée (> 150-200 ng/mL) oriente vers un macroprolactinome. Un syndrome tumoral (céphalées + hémianopsie bitemporale) impose l'imagerie hypophysaire sans délai.

△ RED FLAGS / URGENCES

- Macroadénome compressif (champ visuel, apoplexie hypophysaire)
- Ne pas confondre avec hypothyroïdie (réversible)

INTERROGATOIRE CIBLÉ

Causes les plus fréquentes

- Consommation d'alcool (quantifier réellement) ?
- Surpoids/syndrome métabolique, stéatose (NAFLD) ?
- Médicaments inducteurs enzymatiques (anticonvulsivants, certains) ?

Cholestase

- Prurit, ictère, selles décolorées, urines foncées ?
- PAL associées élevées (cholestase) ?

Autres

- Insuffisance cardiaque (foie de stase), diabète ?

DIFFÉRENTIELS & SIGNES DISCRIMINANTS

Alcool / stéatose métabolique	Les 2 causes dominantes d'élévation isolée
Induction enzymatique médicamenteuse	GGT ↑ isolée, sans cholestase vraie
Cholestase débutante	GGT + PAL élevées ensemble → explorer les voies biliaires
Foie cardiaque	Contexte d'insuffisance cardiaque

PATHOGNOMONIQUE / ORIENTATION FORTE

Une élévation ISOLÉE des GGT (PAL et transaminases normales) est le plus souvent banale (alcool, stéatose, induction enzymatique) et ne justifie pas d'emblée un bilan lourd. C'est l'association GGT + PAL qui définit la cholestase et impose l'imagerie des voies biliaires.

▲ RED FLAGS / URGENCES

- Cholestase (GGT + PAL) → obstacle biliaire/cancer
- Hépatopathie alcoolique avancée

59 Élévation des transaminases (cytolyse)

INTERROGATOIRE CIBLÉ

Ampleur et cinétique

- Modérée chronique (< 5N) vs majeure (> 10N = hépatite aiguë) ?
- Aiguë (virale, toxique, ischémique) vs chronique ?

Étiologies

- Alcool (ASAT > ALAT) ? Surpoids/stéatose (NAFLD) ?
- Médicaments hépatotoxiques (paracétamol surtout en surdosage, statines, antituberculeux, méthotrexate, antifongiques azolés, AINS) ?
- Hépatite virale (B, C, A, E) : FdR, voyage ?
- Cause non hépatique : musculaire (CPK), hémolyse, thyroïde ?

Gravité

- TP/INR (insuffisance hépatocellulaire), ictère, encéphalopathie ?

DIFFÉRENTIELS & SIGNES DISCRIMINANTS

Stéatopathie métabolique / alcoolique	Cytolyse modérée chronique, la plus fréquente
Hépatite médicamenteuse/toxique	Paracétamol (massive), antituberculeux, statines, azolés
Hépatite virale	B/C chronique, A/E aiguë
Cytolyse extra-hépatique	Origine musculaire (vérifier CPK), hémolyse, hyperthyroïdie

PATHOGNOMONIQUE / ORIENTATION FORTE

Pas de pathognomonique. Le rapport ASAT/ALAT (> 1-2 oriente vers l'alcool), l'ampleur (> 10N = hépatite aiguë virale/toxique/ischémique) et la prise de PARACÉTAMOL/médicaments guident. Toute cytolyse aiguë impose la mesure du TP (facteur V) pour dépister l'insuffisance hépatique grave.

▲ RED FLAGS / URGENCES

- Hépatite fulminante (TP ↓, facteur V ↓, encéphalopathie)
- Intoxication au paracétamol
- Hépatite ischémique (foie de choc)

INTERROGATOIRE CIBLÉ

Caractériser

- Hypercholestérolémie (LDL) pure, hypertriglycéridémie, ou mixte ?
- ATCD familiaux d'hypercholestérolémie, de maladie CV précoce (forme familiale) ?
- Xanthomes, xanthélasma, arc cornéen précoce ?

Causes secondaires (à éliminer)

- Hypothyroïdie, diabète, syndrome néphrotique, cholestase ?
- Alcool (TG), obésité, médicaments (corticoïdes, œstrogènes, rétinoïdes, certains) ?

Risque global

- Autres FdR CV (tabac, HTA, diabète, âge, ATCD) pour fixer la cible de LDL ?

DIFFÉRENTIELS & SIGNES DISCRIMINANTS

Dyslipidémie commune/polygénique	La plus fréquente, multifactorielle
Hypercholestérolémie familiale	LDL très élevé + xanthomes + ATCD CV précoces → dépistage familial
Dyslipidémie secondaire	Hypothyroïdie, diabète, néphrotique, alcool, iatrogène
Hypertriglycéridémie majeure	Risque de pancréatite aiguë si TG très élevés

PATHOGNOMONIQUE / ORIENTATION FORTE

Pas de pathognomonique en routine ; les dépôts lipidiques (xanthomes tendineux, arc cornéen avant 45 ans) + ATCD CV précoces orientent vers une hypercholestérolémie FAMILIALE. Avant de traiter : éliminer une cause secondaire (TSH, glycémie, créatinine) et raisonner sur le risque CV global.

△ RED FLAGS / URGENCES

- Hypertriglycéridémie majeure (pancréatite aiguë)
- Hypercholestérolémie familiale (risque CV précoce)

INTERROGATOIRE CIBLÉ

Origine musculaire ?

- Myalgies, faiblesse, urines foncées (rhabdomyolyse) ?
- Effort intense, traumatisme, injection IM, crise comitiale, immobilisation ?

Iatrogène (capital)

- STATINE (± fibrates), neuroleptiques (syndrome malin), corticoïdes ?

Causes

- Hypothyroïdie ? Myopathie/myosite (déficit proximal, dermatomyosite) ?
- Cardiaque (mais troponine plus spécifique) ?
- Toxique (alcool, cocaïne) ?

Gravité

- Oligurie, hyperkaliémie (rhabdomyolyse → IRA) ?

DIFFÉRENTIELS & SIGNES DISCRIMINANTS

Rhabdomyolyse	CPK très élevées + myalgies + myoglobulinurie → risque d'IRA et d'hyperkaliémie
Myopathie iatrogène	Statines ++ (myalgies + CPK ↑), syndrome malin des neuroleptiques (urgence)
Myosite inflammatoire	Déficit proximal + CPK ↑ (dermatomyosite/polymyosite)
Hypothyroïdie	CPK ↑ + signes d'hypothyroïdie

PATHOGNOMONIQUE / ORIENTATION FORTE

Vérifier d'abord l'origine MUSCULAIRE (vs effort/IM/comitiale avant prélèvement). CPK massivement élevées + myoglobulinurie = rhabdomyolyse (surveiller kaliémie et fonction rénale). Sous STATINE, des myalgies + CPK élevées imposent l'arrêt (risque de rhabdomyolyse, majoré par les fibrates).

△ RED FLAGS / URGENCES

- Rhabdomyolyse (IRA, hyperkaliémie)
- Syndrome malin des neuroleptiques
- Myocardite/SCA (préférer la troponine)

INTERROGATOIRE CIBLÉ

Contexte (LDH = marqueur très peu spécifique)

- Hémolyse (du prélèvement OU vraie : anémie, ictère, haptoglobine) ?
- Lyse tissulaire : infarctus (myocarde, pulmonaire), rhabdomyolyse ?
- Hémopathie/néoplasie (lymphome : LDH = marqueur pronostique), syndrome de lyse ?
- Hépatopathie, atteinte musculaire ?

DIFFÉRENTIELS & SIGNES DISCRIMINANTS

Hémolyse	Vraie (anémie hémolytique : LDH ↑ + haptoglobine ↓ + bili libre ↑) ou artefactuelle
Néoplasie/hémopathie	Lymphome (valeur pronostique), tumeurs à fort turn-over
Nécrose tissulaire	Infarctus, rhabdomyolyse, ischémie
Autres	Hépatopathie, macro-LDH, atteinte musculaire

PATHOGNOMONIQUE / ORIENTATION FORTE

La LDH est un marqueur de lyse cellulaire NON spécifique : elle n'a de valeur qu'interprétée dans un contexte. Triade hémolyse = LDH ↑ + haptoglobine effondrée + bilirubine libre ↑. Dans les lymphomes, elle a une valeur pronostique. Éliminer une hémolyse de prélèvement.

△ RED FLAGS / URGENCES

- Anémie hémolytique aiguë (MAT : LDH ↑ + schizocytes + thrombopénie → urgence)
- Syndrome de lyse tumorale
- Lymphome agressif

63 Conduite à tenir devant une anémie

INTERROGATOIRE CIBLÉ

Tolérance d'abord

- Dyspnée, asthénie, angor, tachycardie, malaise (mauvaise tolérance → transfusion) ?
- Rapidité d'installation (aiguë mal tolérée vs chronique tolérée) ?

Saignement

- Extériorisé (méléna, ménorragies, hématurie) ou occulte (digestif) ?

Orientation par le VGM

- Microcytaire : carence martiale (saignement chronique ++), inflammation, thalassémie ?
- Macrocytaire : carence B9/B12, alcool, hypothyroïdie, myélodysplasie, médicaments ?
- Normocytaire : régénérative (hémolyse, hémorragie aiguë) vs arégénérative (IRC, inflammation, envahissement) — réticulocytes ?

DIFFÉRENTIELS & SIGNES DISCRIMINANTS

Anémie microcytaire ferriprive	Carence martiale (ferritine basse) → CHERCHER le saignement (digestif si homme/femme ménopausée)
Anémie macrocytaire carentielle	B12/folates, alcool, hypothyroïdie, myélodysplasie
Anémie normocytaire régénérative	Hémolyse (LDH ↑, haptoglobine ↓) ou saignement aigu
Anémie normocytaire arégénérative	Inflammation, IRC (EPO ↓), insuffisance médullaire

PATHOGNOMONIQUE / ORIENTATION FORTE

L'algorithme repose sur VGM + réticulocytes. Une anémie microcytaire ferriprive chez un homme ou une femme ménopausée = saignement digestif jusqu'à preuve du contraire (endoscopies). Réticulocytes élevés = régénérative (périphérique) ; bas = centrale.

△ RED FLAGS / URGENCES

- Mauvaise tolérance (angor, défaillance) → transfusion
- Saignement actif
- Pancytopenie (leucémie aiguë, aplasie)
- Anémie hémolytique avec schizocytes (MAT)

INTERROGATOIRE CIBLÉ

Caractériser

- Dyspnée, douleur basithoracique, toux ?
- Unilatéral/bilatéral, abondance, tolérance ?
- Fièvre, AEG, contage tuberculeux ?

Orientation transsudat vs exsudat

- Insuffisance cardiaque, cirrhose, syndrome néphrotique (transsudat, souvent bilatéral) ?
- Néoplasie/AEG, infection (pleurésie purulente), TB, EP (exsudat) ?

Terrain

- Tabac, ATCD néo, exposition amiante (mésothéliome) ?

DIFFÉRENTIELS & SIGNES DISCRIMINANTS

Transsudat	Critères de Light négatifs : insuffisance cardiaque, cirrhose, néphrotique → traiter la cause
Exsudat	Critères de Light positifs → ponction + analyse (cytologie, biochimie, bactério)
Pleurésie infectieuse/purulente	Fièvre + liquide trouble → drainage
Pleurésie néoplasique	Liquide exsudatif souvent hémorragique, récidivant, AEG

PATHOGNOMONIQUE / ORIENTATION FORTE

Les critères de LIGHT distinguent transsudat (cause systémique : cœur, foie, rein) d'exsudat (cause pleurale locale : infection, cancer, TB, EP). Tout exsudat non étiqueté impose une exploration. Un épanchement fébrile purulent = pleurésie à drainer en urgence.

△ RED FLAGS / URGENCES

- Pleurésie purulente (drainage)
- Épanchement compressif mal toléré
- Hémothorax
- Épanchement néoplasique / mésothéliome
- Embolie pulmonaire